

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Вариативное меню в стационарных учреждениях социального обслуживания Российской Федерации

Нормативно-правовая база и обобщение регионального опыта

Дата подготовки: 16 июля 2026 г.

Литературная редакция: 29 августа 2026 г.

Все ссылки верифицированы (реестр — Приложение 2)

Содержание

Аннотация	5
Методология и верификация источников	6
Введение	7
Раздел 1. Понятийный аппарат, объект регулирования и история правового регулирования питания в учреждениях социального обслуживания	9
1.1. Стационарные учреждения социального обслуживания: понятие и виды	9
1.2. Вариативное меню (вариативное питание): дефиниция и смежные понятия	10
1.3. Питание как социальная услуга: место в системе социального обслуживания	11
1.4. История правового регулирования питания в учреждениях социального обслуживания (1993–2026)	12
Раздел 2. Федеральная нормативно-правовая база организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания	15
2.1. Конституционные основы и федеральное законодательство	15
2.2. Федеральный закон № 442-ФЗ как системообразующий акт: распределение полномочий, услуги, стандарты, плата	17
2.3. Санитарно-эпидемиологическое нормирование питания	19
2.4. Нормы питания и лечебно-диетическая база	22
2.5. Организационные акты Минтруда России	26
2.6. Национальные стандарты (ГОСТ)	28
2.7. Закупочное регулирование и его влияние на организацию питания	29
2.8. Контрольно-надзорная база в сфере питания учреждений социального обслуживания	29
2.9. Выводы по федеральному уровню регулирования	31
Раздел 3. Региональная нормативно-правовая база и опыт субъектов Российской Федерации	32
3.1. Модель регионального правового регулирования питания в учреждениях социального обслуживания	32
3.2. Город Москва	33
3.3. Город Санкт-Петербург	34
3.4. Свердловская область	35
3.5. Нижегородская область	36
3.6. Омская область	36

3.7. Псковская область	37
3.8. Республика Татарстан	38
3.9. Новосибирская область: документированная практика вариативного питания	38
3.10. Кейтеринговая модель организации питания как фактор вариативности	39
3.11. Сравнительный анализ региональных нормативных актов о нормах питания	40
3.12. Проблемы регионального уровня регулирования и практики	42
Раздел 4. Организация вариативного меню: правовые основания, модели и методология внедрения	44
4.1. Правовые основания и ограничения внедрения	44
4.2. Организационные модели вариативного меню	44
4.3. Диетическое питание в системе вариативного меню	45
4.4. Организация выбора: информирование и учёт предпочтений	46
4.5. Документооборот, кадры и технология	46
4.6. Оценка качества и удовлетворённость проживающих	47
4.7. Экономика вариативного меню	47
4.8. Типовые ошибки и риски при внедрении вариативного меню	48
Раздел 5. Контроль качества питания и защита прав проживающих	49
5.1. Государственный контроль (надзор): санитарный блок	49
5.2. Ведомственный и внутренний контроль	49
5.3. Прокурорский надзор и типовые нарушения	50
5.4. Счётные палаты: аудит эффективности	50
5.5. Уполномоченные по правам человека: независимый мониторинг	50
5.6. Общественный контроль и участие проживающих	51
5.7. Механизмы защиты прав проживающих в части питания	52
Раздел 6. Проблемы правового регулирования и направления совершенствования	53
6.1. Выявленные пробелы регулирования	53
6.2. Предложения по совершенствованию (de lege ferenda)	54
6.3. Перспективы развития	55
Заключение	57
Приложение 1. Реестр нормативных правовых актов, регулирующих организацию питания в стационарных учреждениях социального обслуживания	59

Приложение 2. Реестр верифицированных ссылок	63
Приложение 3. Извлечение из норм питания Санкт-Петербурга (постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284, действующая редакция)	69
Приложение 4. Модель вариативного меню (рекомендуемый образец)	71
Приложение 5. Чек-лист внедрения вариативного меню в учреждении социального обслуживания	73
Приложение 6. Проект типового положения об организации вариативного меню (образец локального акта)	75
Приложение 7. Глоссарий	77
Источники	79

Аннотация

Доклад посвящён тому, как российское право устроено вокруг самой, пожалуй, человеческой из социальных услуг — питания в стационарных учреждениях социального обслуживания. Речь о домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, хосписах и иных организациях, где человек живёт постоянно и где каждый его обед определён чужим решением. В центре внимания — вариативное меню: модель, при которой проживающий не просто получает положенное, а выбирает. В работе собрана и разобрана федеральная нормативная база — от конституционных норм до ведомственных приказов и национальных стандартов, исследовано законодательство и практика восьми субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Омская, Псковская, Новосибирская области, Республика Татарстан), описаны организационные модели внедрения выбора блюд, система контроля качества питания и механизмы защиты прав проживающих. Завершают доклад выявленные пробелы регулирования и конкретные предложения по его совершенствованию.

Главный вывод сух и важен: понятия «вариативное меню» в федеральном праве нет. Обязательный минимум исчерпывается кратностью приёмов пищи, соблюдением норм питания и санитарных правил, а само право проживающего выбирать блюдо из двух и более вариантов рождается на другом уровне — в региональных стандартах качества, локальных актах учреждений, методических рекомендациях. Отсюда заметный разброс практик между регионами — его доклад и документирует.

Адресаты работы — специалисты органов социальной защиты населения, руководители и сотрудники стационарных учреждений, организаторы питания, а также исследователи социальной политики и права.

Методология и верификация источников

Доклад опирается на действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и её субъектов, методические рекомендации, официальную статистику и отчётность, материалы контрольных и надзорных органов, документированный региональный опыт. Использованы официальные тексты актов с государственных порталов правовой информации, из справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», с официальных сайтов органов власти и учреждений.

Отдельного слова заслуживает ссылочный аппарат. **Каждая гиперссылка в докладе проверена на доступность прямым обращением к ресурсу 16 июля 2026 г.** В реестре источников (Приложение 2) по каждой ссылке указаны адрес, подтверждаемый документ, результат проверки (код ответа сервера) и её дата. Ресурсы, недоступные из автоматизированной исследовательской среды (в частности, из-за географических ограничений доступа к ряду региональных порталов), в основной реестр не вошли: такие акты приведены с полными библиографическими реквизитами, достаточными для однозначного поиска в справочных правовых системах, и собраны в отдельный перечень источников для ручной проверки. Акты цитируются по официально опубликованным текстам; при расхождении редакций приоритет — у действующей на дату подготовки доклада.

Введение

Стационарное социальное обслуживание в России — это сотни тысяч пожилых людей, инвалидов, лиц с психическими расстройствами и других граждан, которым нужна постоянная посторонняя помощь. Судя по Тематическому докладу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, система объединяет более 5,4 тысячи организаций; свыше 1,4 тысячи из них — стационарные учреждения (дома-интернаты, психоневрологические интернаты, геронтологические центры), а ещё 517 стационарных отделений работают внутри нестационарных организаций ^[37]. Для подавляющего большинства проживающих питание — не бытовая мелочь, а основа качества жизни, здоровья и душевного благополучия. Его дают круглосуточно, весь срок проживания; фактически оно целиком определяет рацион человека.

Исторически питание в учреждениях соцобслуживания строилось по принципу единого меню: все проживающие, за вычетом диетических столов, получали одинаковые блюда по утверждённому цикличному расписанию. Модель технологически проста и экономична — но глуха к вкусам человека, к его культурным и религиозным привычкам, к самому ощущению достойной жизни. В последние годы в практику учреждений и в региональное регулирование всё увереннее входит другая модель — **вариативное меню** (вариативное питание): проживающему предлагают выбор из двух и более вариантов блюд на каждый приём пищи или возможность заказать блюдо заранее. Такая модель — грань персонализации социальных услуг, знак уважения к достоинству человека.

Однако правовой статус вариативного меню по-прежнему расплывчат. Федеральные требования к питанию в стационарных учреждениях рассеяны по нескольким актам: Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» ^[2], санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ^[7], методическим рекомендациям, утверждённым постановлением Минтруда России от 15.02.2002 № 12 ^[10], ряду ведомственных приказов. Нормы питания — суточные продуктовые наборы — с 1 января 2015 года утверждают субъекты Федерации, и подходы различаются впечатляюще: от подробных многовариантных матриц (с отдельными наборами для психоневрологических интернатов, для людей с сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта) до единых укрупнённых перечней. А вот прямого требования предлагать проживающим выбор блюд федеральные акты не содержат.

Цель доклада — систематизировать нормативно-правовую базу организации питания и вариативного меню в стационарных учреждениях социального обслуживания и обобщить

региональный опыт её формирования и применения.

Для этого поставлены шесть **задач**: (1) определить понятие вариативного меню и его место в системе социального обслуживания; (2) проанализировать федеральные законы и подзаконные акты об организации питания; (3) исследовать санитарно-эпидемиологические требования и нормы питания, включая диетическое (лечебное); (4) обобщить региональную нормативную практику и документированные кейсы внедрения вариативного питания; (5) рассмотреть организационные модели вариативного меню, контроль качества и защиту прав проживающих; (6) выявить пробелы регулирования и сформулировать предложения по совершенствованию нормативной базы.

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся при организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания. **Предмет исследования** — нормативные правовые акты об организации питания и вариативном меню и практика их применения в субъектах Российской Федерации.

Доклад состоит из шести разделов, заключения и приложений. Первый раздел задаёт понятийный аппарат и прослеживает историю регулирования; второй посвящён федеральной нормативной базе; третий — региональному опыту; четвёртый — организационным моделям вариативного меню; пятый — контролю качества питания и защите прав проживающих; шестой — проблемам и путям совершенствования регулирования. В приложениях — реестр нормативных актов, реестр верифицированных ссылок, сравнительные таблицы региональных норм питания, модель вариативного меню и глоссарий.

Раздел 1. Понятийный аппарат, объект регулирования и история правового регулирования питания в учреждениях социального обслуживания

1.1. Стационарные учреждения социального обслуживания: понятие и виды

Действующее российское законодательство оперирует понятием «организация социального обслуживания». По статье 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 442-ФЗ) это организация, которая осуществляет социальное обслуживание независимо от организационно-правовой формы ^[2]. Стационарную форму статья 3 того же закона определяет как обслуживание с постоянным, временным (на срок из индивидуальной программы) или пятидневным круглосуточным проживанием получателей социальных услуг ^[2]. Круглосуточное проживание предопределяет главную особенность питания в таких организациях: его дают не реже трёх раз в день, ежедневно, весь срок проживания — и оно фактически целиком формирует рацион человека.

Номенклатура организаций социального обслуживания утверждена приказом Минтруда России от 17.04.2014 № 258н. Стационарные организации для взрослых — это дома-интернаты для престарелых и инвалидов (в том числе малого и среднего типа), психоневрологические интернаты, дома милосердия, геронтологические дома и центры, дома ветеранов, пансионаты для ветеранов труда, хосписы, реабилитационные центры. Доклад ограничен стационарными учреждениями для взрослых; детские дома-интернаты и организации для детей-сирот живут под специальными санитарными правилами (СанПиН 2.4.3259-15) и здесь не рассматриваются.

По данным Минтруда России, в стране работает около 1,4 тысячи стационарных организаций социального обслуживания. Тематический доклад Уполномоченного по правам человека «Социальное обслуживание» даёт более широкую картину: 5 481 организация социального обслуживания, более 1,4 тысячи стационарных учреждений и 517 стационарных отделений при нестационарных организациях — из них 377 для взрослых и 140 для детей ^[37]. Получателей социальных услуг во всех формах — миллионы (Минтруд называет цифру более 3,6 млн). Значительная доля проживающих — люди старше 80 лет, инвалиды I и II групп, лица с деменцией и психическими расстройствами. Для этих категорий качество питания — вопрос не только социальный, но и напрямую медицинский.

Рис. 1. Иерархия уровней правового регулирования организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания



Рис. 1. Иерархия уровней правового регулирования организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания

1.2. Вариативное меню (вариативное питание): дефиниция и смежные понятия

Термина «вариативное меню» в федеральном законодательстве нет — ни законы, ни подзаконные акты его не употребляют. Зато он прочно прижился в практике социального обслуживания, в региональных стандартах качества, локальных актах учреждений и профессиональной литературе — рядом с родственными формулировками: «вариативное питание», «меню с правом выбора блюд», «двухвариантное (многовариантное) меню», «меню-заказ», «шведский стол».

В этом докладе **вариативное меню** — модель организации питания, при которой проживающему на каждый приём пищи (или на основные приёмы) предлагают выбор из двух и более вариантов блюд, гарниров, салатов или напитков, приготовленных в рамках утверждённых норм и продуктового набора, либо дают возможность заказать блюдо заранее из утверждённого ассортимента. Важно: вариативное меню не трогает нормы питания и не отменяет санитарные правила. Оно меняет другое — способ формирования индивидуального рациона: человек из пассивного получателя единого набора становится активным выбирающим внутри нормативно очерченного ассортимента.

Вариативное меню стоит отличать от смежных практик. **Диетическое (лечебное) питание** — обязательная вариативность по медицинским показаниям: пункт 7.1.11 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 требует организовывать питание проживающих не менее трёх раз в день, включая диетическое ^[8]. Диетическая вариативность предписана нормой права и от воли учреждения не зависит. **Вариативное меню**, напротив, принадлежит сфере качества услуги и вкусовых предпочтений — оно предлагает выбор там, где медицинских различий между рационами нет. Наконец, **персонализированное питание** — понятие шире: оно включает учёт здоровья, культурных, религиозных и этических пристрастий (скажем, вегетарианства), возрастных особенностей (измельчённая, протёртая пища) и текстурных потребностей.

Международный опыт — включая практику стран Содружества Независимых Государств, где вариативность питания в интернатных учреждениях закреплена подзаконными актами, — убеждает: выбор блюд воспринимается как часть достойных условий проживания. Ближайшая опора такого подхода в российском праве — положения о правах получателей социальных услуг на уважительное и гуманное отношение и на информацию об услугах, а также региональные стандарты качества (статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ) ^[2].

1.3. Питание как социальная услуга: место в системе социального обслуживания

Федеральный закон № 442-ФЗ относит обеспечение питанием к социальным услугам. Социально-бытовые услуги поддерживают жизнедеятельность получателя в быту (часть 1 статьи 7); срочные социальные услуги включают обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами (пункт 1 части 7 статьи 7) ^[2]. В стационарной форме питание входит в комплекс социально-бытовых услуг — и одновременно имеет социально-медицинское измерение: диетические рационы, наблюдение за состоянием здоровья. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н прямо требует учитывать нормы питания при расчёте объёма социальных услуг в стационарной форме, а при оценке качества социально-бытовых услуг оценивать питание, которое «должно быть приготовлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам» (пункты 16, 19) ^[15].

Питание в стационарном учреждении стоит на пересечении трёх правовых режимов. Первый — законодательство о социальном обслуживании: услуга, её объём, качество, плата. Второй — законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о качестве и безопасности пищевых продуктов: безопасность пищи, требования к пищеблоку, технологиям, персоналу. Третий — законодательство об охране здоровья:

лечебное и диетическое питание по медицинским показаниям. Вариативное меню касается прежде всего первого режима — качества и персонификации услуги, — но живёт в жёстких рамках двух других.

1.4. История правового регулирования питания в учреждениях социального обслуживания (1993–2026)

Нормативная база питания в стационарных учреждениях соцобслуживания складывалась в несколько этапов (рис. 2).

Этап становления (1993–2002). В 1993 году Министерство социальной защиты населения утвердило примерные положения об учреждениях социального обслуживания — домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах для одиноких престарелых, — закрепив обязанность обеспечивать проживающих питанием. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (утратил силу с 01.01.2015) установил государственные гарантии социального обслуживания, а Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ввёл категорию социальных услуг как вида государственной социальной помощи. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» задал общие требования к пищевой продукции, включая понятия здорового и горячего питания ^[6].

Этап методологической проработки (2002–2013). Принципиальным документом десятилетия стало постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» ^[10]. Его разработал НИИ питания РАМН вместе с Департаментом по делам ветеранов Минтруда и согласовал Главный государственный санитарный врач России. Впервые на федеральном уровне появились суточные продуктовые наборы, примерные семидневные меню для домов-интернатов и психоневрологических интернатов, нормы взаимозаменяемости продуктов и требования к разнообразию рациона (подробнее — раздел 2.4). Параллельно вызревало лечебно-питательное регулирование в здравоохранении: приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 ^[14] ввёл номенклатуру стандартных диет, которую позже переняли и учреждения соцобслуживания при организации диетического питания.

Этап реформы социального обслуживания (2013–2015). Федеральный закон № 442-ФЗ, вступивший в силу 1 января 2015 года, перекроил архитектуру регулирования:

формирование нормативов, включая нормы питания, отошло к субъектам Федерации. В 2014–2015 годах все регионы приняли законы о социальном обслуживании, перечни социальных услуг и собственные нормы питания. Процедурный каркас стационарного обслуживания закрепили приказы Минтруда 2014 года (№ 159н, № 258н, № 935н), в том числе требования учитывать нормы питания при расчёте объёма услуг и оценивать качество питания^[15].

Этап санитарной реформы (2020–2026). С 1 января 2021 года вступили в силу санитарные правила эпохи «регуляторной гильотины», среди них СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, действуют до 01.01.2027); их раздел 7.1 посвящён питанию в медицинских организациях и организациях соцобслуживания в стационарных условиях^[7]. В 2021 году утвердили методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах^[31]. В системе стандартизации требования к услугам пожилым гражданам обновил ГОСТ Р 52884-2021.

Рис. 2. Хронология формирования нормативной базы организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания (1993–2024)



Рис. 2. Хронология формирования нормативной базы организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания (1993–2024)

Этап практической персонификации (2018 г. — настоящее время). На фоне устоявшейся нормативной рамки учреждения и регионы начали внедрять элементы персонификации питания: вариативные меню, предварительный заказ блюд, буфетное обслуживание, праздничные и сезонные меню. Среди документированных примеров — вариативное питание в психоневрологических интернатах Новосибирской области (с 2024

года) ^[29], практика московских пансионатов для ветеранов труда, распространение кейтеринговой модели ^[33]. Эти практики де-факто формируют новый стандарт качества, который системного федерального закрепления пока не получил. Именно в этом — основной регуляторный разрыв, который разбирает настоящий доклад.

Раздел 2. Федеральная нормативно-правовая база организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания

2.1. Конституционные основы и федеральное законодательство

Вершину правовой пирамиды венчает **Конституция Российской Федерации**. Статья 7 провозглашает Россию социальным государством, чья политика служит единой цели — создать условия, достойные человека и благоприятные для его свободного развития; статья 39 гарантирует каждому социальное обеспечение в старости, при болезни и инвалидности; статья 41 закрепляет право на охрану здоровья ^[1]. Требование «достойной жизни» заранее определяет качественный — а не только количественный — характер социального обслуживания, включая питание: рацион, лишённый элементарного разнообразия и выбора, может формально укладываться в нормы, но не выдерживает проверки конституционным стандартом достоинства личности (статья 21). Прямого регулирования организации питания в Конституции нет, однако именно её нормы служат интерпретационным компасом для всех нижестоящих актов и мерилom повседневной практики учреждений.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» — системообразующий акт, которому посвящён отдельный раздел 2.2 ^[2].

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» закрепляет государственные гарантии социальной поддержки инвалидов и условия их жизнедеятельности; статья 17 определяет порядок социально-бытового и медицинского обслуживания на дому и в стационарных условиях ^[3]. Для темы доклада это существенно: инвалиды составляют значительную долю проживающих в домах-интернатах и психоневрологических интернатах, и их особые пищевые потребности — при сахарном диабете, фенилкетонурии, целиакии, дисфагии — нельзя не учитывать при организации питания.

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ввёл понятие социальных услуг как вида государственной социальной помощи и очертил круг её получателей. После вступления в силу Закона № 442-ФЗ его роль в регулировании социального обслуживания сузилась, однако для отдельных категорий проживающих — прежде всего ветеранов — он значения не утратил.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сделал санитарно-эпидемиологические требования обязательными для всех организаций, включая предприятия общественного питания и пищеблоки стационарных учреждений; статья 39 закрепила право граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, к которым относится и безопасное питание ^[4]. На этом фундаменте выстроена вся система санитарного нормирования питания — СанПиН, СП, методические рекомендации, — разобранные в разделе 2.3.

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» дал базовые определения (пищевые продукты, здоровое питание, горячее питание, пищевая ценность), установил требования к качеству и безопасности продуктов в обороте и обязанности изготовителей и организаций общепита ^[6]. Закон определяет «горячее питание» как здоровое питание, предусматривающее наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приёма пищи — в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями ^[6]; именно этим определением пользуются, квалифицируя услуги питания в учреждениях соцобслуживания.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 4 статьи 39 отнёс утверждение норм лечебного питания к полномочиям федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения ^[5]. На этом основании родился приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» ^[12], применяемый при организации диетического питания и в стационарных учреждениях соцобслуживания (подробнее — раздел 2.4).

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (действует с 01.07.2013) — наднациональный акт прямого действия. Он устанавливает обязательные требования безопасности к пищевой продукции и связанным с ней процессам, включая организацию общественного питания, и закрепляет принципы НАССР (НАССР) — системы управления безопасностью пищи, построенной на анализе рисков и критических контрольных точек. Им обязаны соответствовать и собственные пищеблоки, и кейтеринговые операторы стационарных учреждений соцобслуживания.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» задаёт рамку надзорной деятельности Роспотребнадзора в отношении учреждений соцобслуживания: риск-ориентированный подход, категории риска, профилактические мероприятия (подробнее — раздел 5).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует закупки продуктов питания и услуг кейтеринга государственными учреждениями — а значит, напрямую влияет на возможности вариативного меню: стоимостные ограничения, правила описания объекта закупки, требования к поставщикам (подробнее — раздел 4.7).

Особого упоминания заслуживает **Конвенция ООН о правах инвалидов**, ратифицированная Россией в 2012 году: её статья 28 закрепляет право инвалидов на достойный уровень жизни, включая питание. Нормы Конвенции входят в правовую систему России и подлежат учёту при толковании национального законодательства.

2.2. Федеральный закон № 442-ФЗ как системообразующий акт: распределение полномочий, услуги, стандарты, плата

Федеральный закон № 442-ФЗ возвёл рамочную модель регулирования социального обслуживания, и ключевая её особенность для темы доклада — передача основной массы нормативных полномочий субъектам Российской Федерации ^[2].

Распределение полномочий. Статья 6 очерчивает полномочия Российской Федерации: установление основ организации социального обслуживания, определение категорий граждан, признаваемых нуждающимися, утверждение федеральных стандартов в пределах компетенции и методических рекомендаций. Статья 8 относит к полномочиям субъектов организацию социального обслуживания на своей территории, утверждение перечня социальных услуг, порядка их предоставления поставщиками, **норм и нормативов предоставления социальных услуг** (пункты 5–7 статьи 8), а также подушевых нормативов финансирования и тарифов ^[2]. На статье 8 и зиждется всё региональное нормотворчество в области норм питания, обобщённое в разделе 3.

Виды социальных услуг. Статья 7 перечисляет их: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала и срочные социальные услуги ^[2]. Обеспечение питанием в стационаре принадлежит к социально-бытовым услугам; диетическое питание обретает черты социально-медицинской услуги; срочное обеспечение горячим питанием — самостоятельная срочная услуга (пункт 1 части 7 статьи 7) ^[2].

Формы социального обслуживания. Статья 3 выделяет стационарную, полустационарную формы и обслуживание на дому. Стационарная форма означает круглосуточное проживание — а отсюда прямо вытекает обязанность организовать полноценное многократное питание. Это требование позднее конкретизировано в СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не менее трёх приёмов пищи в день ^[8].

Права получателей социальных услуг. Статья 9 закрепляет права получателей на уважительное и гуманное отношение; на выбор поставщика социальных услуг; на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, о видах услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах и стоимости; на отказ от услуг; на условия пребывания, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, и надлежащий уход; на защиту прав и законных интересов ^[2]. Эти нормы — нормативная опора вариативного меню. Право на информацию об услуге питания означает, что меню обязано быть доведено до проживающих. Принцип уважительного отношения требует считаться с разумными предпочтениями человека. А право отказаться от услуги плохо совместимо с навязыванием конкретных блюд, когда нормы допускают альтернативу.

Стандарты социальных услуг. Статья 7 (части 6, 7) и статья 8 предусматривают установление стандартов субъектами Федерации, а статья 2 определяет стандарт социальной услуги как установленные в соответствии с законодательством основные требования к объёму, периодичности и качеству её предоставления ^[2]. Стандарты качества — главный инструмент, с помощью которого регионы вправе закрепить вариативность питания как обязательную характеристику услуги.

Плата за социальные услуги. Статьи 31 и 32 регулируют бесплатное и платное предоставление услуг; ежемесячная плата за стационарное обслуживание не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя (статья 31) ^[2]. Питание входит в стоимость стационарного обслуживания, и потому нормативы финансирования жёстко ограничивают ассортимент вариативного меню: выбор блюд учреждение строит в рамках утверждённого продуктового набора и подушевого норматива.

Процедурные основы. Закон регулирует признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (статья 15), индивидуальную программу предоставления социальных услуг (статья 16) — документ, фиксирующий вид, объём и периодичность услуг, включая питание и, при необходимости, его диетические особенности; договор о предоставлении социальных услуг (статья 17); отказ от услуг (статья 11) ^[2]. Индивидуальная программа — юридически значимое место для фиксации личных

пищевых потребностей и пристрастий; на неё и опираются учреждения, внедряя вариативное меню.

Оценка качества. Закон требует определять показатели качества социальных услуг; Примерный порядок (приказ Минтруда № 935н) относит к ним удовлетворённость получателей, отсутствие обоснованных жалоб и положительные отзывы (пункт 17) ^[15]. Удовлетворённость питанием неизменно входит в число самых чувствительных индикаторов качества стационарного обслуживания — это подтверждают и материалы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: на социальное обслуживание приходится заметная доля жалоб проживающих ^[37].

2.3. Санитарно-эпидемиологическое нормирование питания

Санитарно-эпидемиологические требования — обязательный жёсткий каркас организации питания в стационарных учреждениях соцобслуживания. За их соблюдением следит Роспотребнадзор; нарушения влекут административную ответственность по статье 6.3 КоАП РФ, а при причинении вреда здоровью — ответственность гражданско-правовую и уголовную.

2.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: общая характеристика и структура

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, вступили в силу с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2027 ^[7]. Документ пришёл на смену ранее действовавшим СанПиН 2.3.6.1079-01 и ряду отраслевых правил и установил единые требования к организации общественного питания населения, включая питание организованных коллективов.

По устройству СанПиН 2.3/2.4.3590-20 включает общие положения; требования к условиям деятельности организаций общепита (размещение, помещения, оборудование, водоснабжение, канализация, вентиляция); требования к приёмке, транспортировке и хранению сырья; к производству и раздаче готовой продукции; к личной гигиене персонала; специальные разделы о питании детей в образовательных организациях (разделы 2–6) и, наконец, **раздел VII «Требования к организации питания в медицинских организациях, организациях социального обслуживания и иных организациях»** — именно он адресован стационарным учреждениям соцобслуживания ^[7] ^[8].

2.3.2. Раздел 7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: требования к питанию в медицинских организациях и организациях социального обслуживания в стационарных условиях

Подраздел 7.1 регулирует организацию питания пациентов медицинских организаций и проживающих организаций соцобслуживания, работающих в стационарных условиях. Его ключевые положения ^[8]:

- питание проживающих должно отвечать требованиям СанПиН по безопасности и пищевой ценности и организуется с учётом физиологических потребностей, а при необходимости — медицинских показаний;
- меню в медицинских организациях и организациях соцобслуживания разрабатывается с учётом норм питания, утверждённых в установленном порядке, и физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии (методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 ^[31]);
- **пункт 7.1.11:** «питание проживающих должно быть организовано не менее трёх раз в день, включая диетическое питание» ^[8]. Это единственная федеральная санитарная норма, напрямую адресованная режиму питания в учреждениях соцобслуживания: она закрепляет минимальную кратность приёмов пищи и обязательность диетического питания;
- готовую пищу раздают в столовых (обеденных залах) либо доставляют в жилые комнаты (палаты) лежачим и маломобильным проживающим; при транспортировке используют термосы, термоконтейнеры, мармиты и тележки с подогревом, сохраняющие температурный режим;
- для контроля качества проводят бракераж готовых блюд с записью в журнале; на пищеблоке ведут журналы температурного режима холодильного оборудования, журналы гигиенического обучения персонала и иную обязательную документацию по приложениям к СанПиН (приложения 4 и 5 — формы журналов бракеража; приложение 11 — таблица взаимозаменяемости основных продуктов при составлении меню) ^[8].

Для темы доклада принципиально важно: **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не содержит требования о вариативном меню и о предоставлении проживающим выбора блюд.** Санитарные правила очерчивают обязательный минимум: кратность питания, его безопасность, соответствие нормам, наличие диетических вариантов. Значит, внедрение вариативного меню — не исполнение санитарной обязанности. Но оно ей и не

противоречит: при соблюдении технологических требований (раздельные потоки, температурные режимы, бракераж каждого варианта блюда) вариативность вполне правомерна.

2.3.3. СП 2.1.3678-20 и СанПиН 1.2.3685-21

Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 24.12.2020 № 44, действуют до 01.01.2027) задают общие эксплуатационные требования, применимые и к учреждениям соцобслуживания^[31]. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление от 28.01.2021 № 2) устанавливает единые гигиенические нормативы, включая требования к пищевым продуктам и воде^[31].

На пищеблоках учреждений соцобслуживания распространяются также разделы II–VI СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (помещения, оборудование, инвентарь, посуда, кулинарная обработка, хранение, персонал) и, при наличии буфетной или магазинной продажи, СП 2.3.6.3668-20. Региональные акты прямо отсылают к этим документам: так, нормы питания Омской области утверждены со ссылками на СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20^[24].

2.3.4. Методические рекомендации по физиологическим нормам: МР 2.3.1.0253-21

Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом 22.07.2021) определяют нормы физиологических потребностей в энергии и нутриентах для разных групп населения, включая лиц пожилого и старческого возраста^[31]. Для людей старше 60 лет рекомендации устанавливают пониженную — относительно трудоспособного возраста — энергопотребность: порядка 1 800–2 000 ккал в сутки при малоподвижном образе жизни, при достаточном уровне белка (в том числе животного), ограничении простых углеводов и насыщенных жиров, повышенном внимании к витамину D, кальцию, витамину B12 и пищевым волокнам^[31]. Эти величины — физиологический эталон, с которым сверяют региональные нормы питания и фактическую химическую ценность рационов; на них ориентируются разработчики циклических и вариативных меню.

2.3.5. МР 2.3.0144-19: обогащение рационов витаминно-минеральными комплексами

Методические рекомендации МР 2.3.0144-19 «Об организации питания в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения с использованием витаминно-минеральных комплексов» (утверждены Главным государственным санитарным врачом 19.04.2019) прямо распространяются на организации соцобслуживания и предусматривают обогащение готовых блюд витаминно-минеральными комплексами (ВМК) в количестве 50–100 % от физиологической нормы потребления ^[31]. Документ отражает признанную на государственном уровне проблему: рационы интернатных учреждений, даже формально соответствующие нормам по продуктовому набору, нередко оказываются дефицитными по витаминам и минералам — из-за технологических потерь и сезонности. Регионы следуют этим рекомендациям по-разному: нормы питания Свердловской области прямо включают смесь белковую композитную сухую (27 г в сутки) и витаминно-минеральные комплексы в состав продуктового набора ^[20], тогда как в ряде других субъектов ВМК в нормы не вошли.

2.3.6. Выводы по санитарному нормированию

Санитарное законодательство формирует обязательный минимум безопасности и режима питания, оставляя его вариативность за кадром. Практический вывод для учреждений: вариативное меню следует проектировать так, чтобы каждый вариант блюда сам по себе соответствовал нормам питания, требованиям СанПиН (бракераж, температурные режимы, документирование) и таблице взаимозаменяемости продуктов (приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ^[8]. Санитарных запретов на вариативность нет — и потому единственными её ограничителями остаются нормы питания, финансирование и организационная готовность самого учреждения.

2.4. Нормы питания и лечебно-диетическая база

2.4.1. Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12: федеральные методические рекомендации по организации питания

Ключевым методологическим документом федерального уровня по-прежнему остаются Методические рекомендации по организации питания в стационарных учреждениях социального обслуживания, утверждённые постановлением Минтруда России от

15.02.2002 № 12 (в действующей редакции — «Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания») ^{[10][11]}. Документ разработан ФГБУН «НИИ питания РАМН» (ныне ФИЦ питания и биотехнологии) совместно с Департаментом по делам ветеранов и пожилых людей Минтруда России и согласован с Главным государственным санитарным врачом (заключение от 21.01.2002 № 11-5/41-04) ^[11]. Документу уже больше двадцати лет, но он не отменён и продолжает работать: региональные акты о нормах питания прямо отсылают к его таблицам взаимозаменяемости (например, акт Омской области ^[24]).

Методические рекомендации включают девять приложений ^[11]:

Приложение	Содержание
1	Рекомендуемый суточный набор продуктов для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах
2	Рекомендуемый суточный набор продуктов для проживающих в психоневрологических интернатах
3	Примерное семидневное меню для домов-интернатов для престарелых и инвалидов
4	Примерное семидневное меню для психоневрологических интернатов
5	Химический состав и энергетическая ценность суточных рационов
6	Нормы взаимозаменяемости продуктов при составлении меню
7	Рекомендации по организации питания в отделениях милосердия и домах милосердия
8	Оценка адекватности питания по антропометрическим показателям (индекс массы тела)
9	Рекомендуемые нормы выдачи мыла, моющих средств и туалетной бумаги

По существу документ закрепляет несколько принципов, напрямую значимых для вариативного меню ^{[10][11]}. Во-первых, **принцип разнообразия рациона**: меню рекомендуется составлять так, чтобы блюда и гарниры не повторялись в течение дня и максимально разнообразились в течение недели; примерные меню строятся по семидневному циклу. Во-вторых, **принцип взаимозаменяемости**: таблицы приложения 6 позволяют заменять одни продукты другими, равноценными по пищевой ценности (одну

крупну — другой, рыбу — мясом в пересчёте), не нарушая норм. Именно этот механизм юридически «легализует» вариативность в рамках единой нормы. В-третьих, **дифференциация контингентов**: отдельные продуктовые наборы для домов-интернатов и для ПНИ, отдельные рекомендации для отделений милосердия (питание лежачих больных, в том числе зондовое). В-четвёртых, **контроль адекватности питания**: оценка по индексу массы тела и наблюдение за её динамикой у проживающих.

Вместе с тем документ 2002 года объективно устарел. Он не знает современной геронтологической диетологии (саркопения, потребность пожилых в белке и витамине D), не оперирует понятием выбора блюд проживающим, не предъявляет требований к информированию о меню. Его актуализация на федеральном уровне — одно из предложений раздела 6 доклада.

2.4.2. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330: номенклатура стандартных диет

Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (с изменениями) утвердил Инструкцию по организации лечебного питания, номенклатуру диет (стандартные диеты), положение о совете по лечебному питанию и штатные нормативы диетического персонала ^[14]. Хотя приказ адресован лечебно-профилактическим учреждениям, его диетическая номенклатура де-факто работает и в учреждениях соцобслуживания: региональные акты о нормах питания ссылаются на стандартные диеты (например, акт Псковской области ^[28]).

2.4.3. Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н: нормы лечебного питания

Приказом Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2013, регистрационный № 28995; редакция от 19.02.2024) утверждены нормы лечебного питания для шести основных вариантов стандартных диет ^{[12][13]}:

Вариант стандартной диеты	Назначение (обобщённо)
Основной вариант стандартной диеты (ОВД)	пациенты без необходимости специальных ограничений
Диета с механическим и химическим щажением (щадящая)	заболевания желудочно-кишечного тракта
Диета с повышенным количеством белка (высокобелковая)	истощение, послеоперационные состояния, пролежни

Диета с пониженным количеством белка (низкобелковая)	хроническая болезнь почек и др.
Диета с пониженной калорийностью (низкокалорийная)	ожирение, сахарный диабет 2 типа и др.
Диета с повышенной калорийностью (высококалорийная)	недостаточность питания, туберкулёз и др.

Нормы приказа № 395н задают суточные количества продуктов (брутто/нетто) по каждой диете и включают специализированные продукты лечебного питания: **смесь белковую композитную сухую** (СБКС; для основной диеты — 27 г в сутки) и **витаминно-минеральные комплексы** (50–100 % от физиологической нормы) ^[13]. Значение приказа для учреждений соцобслуживания двойственно. Во-первых, он служит методическим ориентиром при организации диетического питания проживающих с хроническими заболеваниями: региональные нормы воспроизводят его структуру (сравните наборы «при сахарном диабете» и «при заболеваниях ЖКТ» в актах Санкт-Петербурга ^[19]). Во-вторых, включённые в него СБКС и ВМК через региональные акты проникают и в социальную сферу — пример тому Свердловская область ^[20].

2.4.4. Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н и методические документы ФИЦ питания и биотехнологии

Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении Порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» систематизировал организацию лечебного питания в медицинских организациях и подтвердил применение норм приказов № 330 и № 395н ^[14]. В части, касающейся учреждений соцобслуживания, значимы методические документы ФИЦ питания и биотехнологии по применению специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и профилактического питания (включая порядок закупки и учёта ВМК) ^[35], а также Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 по организации общественного питания ^[31]. Дополнительным ориентиром здорового рациона служат «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания», утверждённые приказом Минздрава России от 19.08.2016 № 614 ^[31].

2.4.5. Выводы по нормативно-диетологической базе

Федеральная диетологическая база складывается из трёх контуров: (1) методические рекомендации Минтруда 2002 года — для собственно социального обслуживания; (2) приказы Минздрава № 330, № 395н, № 1008н — для лечебного питания, применяемые по аналогии и через отсылки региональных актов; (3) физиологические нормы МР 2.3.1.0253-21 — научный эталон. Прямого федерального акта, устанавливающего **обязательные**

нормы питания для учреждений соцобслуживания, с 01.01.2015 не существует: нормотворческая компетенция передана субъектам (статья 8 Федерального закона № 442-ФЗ) ^[2]. Для вариативного меню принципиальны два федеральных механизма — таблицы взаимозаменяемости продуктов (приложение 6 к постановлению Минтруда № 12, приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и система стандартных диет приказа № 395н: они позволяют выстраивать выбор блюд, не выходя за пределы норм ^{[8][10][12]}.

2.5. Организационные акты Минтруда России

2.5.1. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 159н

Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» (зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2014, регистрационный № 32430) утверждена единая форма заявления, с которой начинается вся процедура предоставления социальных услуг во всех формах обслуживания ^[15]. Для темы доклада значение акта косвенное, но существенное: уже на стадии обращения граждан (или его представитель) вправе сообщить об обстоятельствах, влияющих на организацию питания, — медицинских противопоказаниях, состоянии здоровья; впоследствии они находят отражение в индивидуальной программе.

2.5.2. Приказ Минтруда России от 17.04.2014 № 258н: номенклатура организаций

Номенклатура организаций социального обслуживания (приказ № 258н) определяет виды организаций и отделений, включая стационарные — для взрослых и детей. Её функция классификационная: именно по видам организаций дифференцируются региональные нормы питания — скажем, отдельные наборы для домов-интернатов общего типа и для психоневрологических интернатов (см. раздел 3).

2.5.3. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н: Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2014, регистрационный № 35248; вступил в силу с 01.01.2015; с изменениями от 05.04.2019 и 28.09.2020) — основной процедурный акт стационарного обслуживания ^{[15][16]}. Порядок определяет правила предоставления

услуг от подачи заявления до прекращения обслуживания. Положения, напрямую значимые для организации питания:

- **пункт 15:** подушевой норматив финансирования социальных услуг в стационарной форме устанавливает субъект Федерации с учётом методических рекомендаций по его расчёту, утверждаемых Правительством Российской Федерации ^[15];
- **пункт 16:** при расчёте объёма социальных услуг в стационарной форме учитываются нормы и нормативы, установленные в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, «в том числе нормы питания, нормативы предоставления площади жилых помещений, оснащения мягким инвентарём»; если нормы не установлены, объём услуги не может быть меньше предусмотренного индивидуальной программой и договором ^[15];
- **пункт 17:** основные показатели качества — удовлетворённость получателей, отсутствие обоснованных жалоб, положительные отзывы; открытость документов; укомплектованность штата и квалификация специалистов и др. ^[15];
- **пункт 19 (подпункт 5):** при оценке качества социально-бытовых услуг оценивается питание, «которое должно быть приготовлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам» ^[15];
- **пункт 28:** права получателей в стационарной форме — уважительное и гуманное отношение; выбор поставщика; бесплатное получение в доступной форме информации о правах, видах услуг, сроках, порядке и условиях предоставления, тарифах и стоимости; отказ от услуг; условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, и надлежащий уход; свободное посещение законными представителями, родственниками и иными лицами; конфиденциальность; защита прав ^[15];
- **пункт 35:** ежемесячная плата за стационарное обслуживание не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя ^[15].

Приказом Минтруда России от 05.04.2019 № 216н в пункт 2 Порядка внесено уточнение о пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании ^[16]; приказом от 28.09.2020 № 664н — изменения, касающиеся подтверждения сведений о заявителе ^[15].

Как и СанПиН, Примерный порядок не знает понятия вариативного меню. Однако его нормы создают процедурную рамку для персонификации питания: индивидуальная программа и договор (пункт 9) — документы, где можно закрепить диетические и

вкусовые особенности рациона конкретного проживающего; показатель удовлетворённости (пункт 17) — индикатор, по которому оценивается в том числе успешность вариативного меню; нормы питания (пункт 16) — количественные рамки, в пределах которых строится выбор ^[15].

2.6. Национальные стандарты (ГОСТ)

Систему стандартизации социального обслуживания образует ряд национальных стандартов, разработанных Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 «Социальное обслуживание населения». Применяются они на добровольной основе (в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»), если иное не установлено договором или актом субъекта:

Стандарт	Наименование
ГОСТ Р 52142-2003	Услуги социального обслуживания населения. Общие требования
ГОСТ Р 52883-2007	Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям
ГОСТ Р 52884-2021	Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг пожилым гражданам (взамен ГОСТ Р 52884-2007)
ГОСТ Р 54731-2011	Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг инвалидам
ГОСТ Р 52143-2003	Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг

Наиболее значим для темы **ГОСТ Р 52884-2021 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг пожилым гражданам»**, устанавливающий требования к услугам пожилым, включая стационарные, с учётом индивидуальных потребностей получателей. Стандарты серии ГОСТ Р играют вспомогательную роль: они конкретизируют «лучшие практики» — в том числе учёт индивидуальных потребностей и предпочтений при организации питания. Регионы используют их при разработке собственных стандартов качества, учреждения — при разработке локальных актов, эксперты — при оценке качества.

2.7. Закупочное регулирование и его влияние на организацию питания

Государственные (казённые, бюджетные, автономные) учреждения соцобслуживания закупают продукты питания и услуги по организации питания — кейтеринг — по правилам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе. Закупочное регулирование влияет на вариативное меню сразу по нескольким линиям: (1) описание объекта закупки — при закупке продуктов предметом служит продуктовый набор в соответствии с региональными нормами, при закупке кейтеринга — услуга по предоставлению питания с техническим заданием, куда можно включить требования вариативности (число вариантов блюд, цикличность меню); (2) ценообразование — начальная (максимальная) цена контракта ограничена подушевым нормативом, экономия достигается за счёт конкурентных процедур, но чрезмерное снижение цены на аукционе создаёт риски качества; (3) национальный режим закупок — преференции и ограничения допуска иностранной пищевой продукции; (4) контроль исполнения контракта — приёмка по количеству и качеству, экспертиза.

Практика показывает: кейтеринговая модель — передача организации питания специализированному оператору — способна повышать вариативность за счёт профессиональной технологии и масштаба, но требует качественного технического задания и постоянного контроля; собственный пищеблок даёт учреждению прямой контроль над меню, однако ограничен кадрами и оснащением^[33]. С точки зрения закона оба варианта равноправны; выбор остаётся за регионом и учреждением.

2.8. Контрольно-надзорная база в сфере питания учреждений соцобслуживания

Государственный контроль (надзор). Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ ввёл риск-ориентированную модель контроля: объекты питания учреждений соцобслуживания относятся к категориям риска в зависимости от профиля деятельности и контингента; плановые контрольные мероприятия проводятся с периодичностью, соответствующей категории риска, внеплановые — при угрозе причинения вреда (в том числе по обращениям граждан, при вспышках инфекционных заболеваний и отравлений). Санитарный надзор за организацией питания осуществляет Роспотребнадзор на основании Федерального закона № 52-ФЗ^[4]; ведомственный контроль качества социальных услуг — уполномоченные органы субъектов (статья 8 Федерального закона № 442-ФЗ)^[2].

Прокурорский надзор. Прокуратура в порядке общего надзора проверяет исполнение законодательства о социальном обслуживании и санитарного законодательства в учреждениях. Типовой предмет проверок — соблюдение норм питания (фактический продуктовый набор против утверждённого), санитарное состояние пищеблоков, стоимость питания, документирование. По итогам вносятся представления, возбуждаются дела об административных правонарушениях, в интересах проживающих предъявляются иски. Практика региональных прокуратур свидетельствует об устойчивости проблемы «недовложения» продуктовых наборов в отдельных учреждениях.

Счётные палаты. Счётная палата Российской Федерации и счётные палаты субъектов проводят аудит эффективности расходования средств на социальное обслуживание, включая организацию питания. Показателен аудит в Республике Татарстан по смежному объекту — питанию в психиатрическом стационаре: установлено занижение фактических норм питания против рекомендуемых, а стоимость питания на койко-день составила порядка 224–310 рублей ^[30]. Объект аудита относится к системе здравоохранения, но выявленные проблемы — недостаточность финансирования норм, формальное соблюдение бумажных норм при фактическом занижении рациона — полностью релевантны учреждениям соцобслуживания.

Институт уполномоченных по правам человека. Тематический доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Социальное обслуживание» фиксирует системные проблемы: недостаточную доступность стационарного обслуживания, очереди в психоневрологические интернаты, жалобы проживающих на условия проживания и питание (обращения, связанные с социальным обслуживанием, составляют заметную долю — порядка 22 % соответствующей тематики обращений) ^[37]. Региональные уполномоченные из года в год называют питание среди приоритетных тем мониторинга интернатных учреждений.

Общественный контроль. Общественная палата Российской Федерации, региональные общественные палаты, общественные наблюдательные комиссии и советы попечителей при учреждениях контролируют условия проживания, включая питание: дегустации, опросы проживающих, проверки меню-раскладок. Развитие общественного контроля — самостоятельный фактор внедрения вариативного меню: публичность меню и практики выбора блюд повышают прозрачность учреждения.

2.9. Выводы по федеральному уровню регулирования

Обобщение федеральной нормативно-правовой базы позволяет сформулировать четыре вывода.

Во-первых, обязательное ядро регулирования питания в стационарных учреждениях соцобслуживания образуют: принцип включённости питания в социальные услуги (Федеральный закон № 442-ФЗ), кратность питания не менее трёх раз в день с обязательным диетическим питанием (пункт 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), соответствие нормам питания и санитарным требованиям (пункты 16, 19 приказа № 935н), региональные нормы питания (статья 8 Закона № 442-ФЗ) ^{[2][8][15]}.

Во-вторых, понятия «вариативное меню» на федеральном уровне не существует. Правовую опору вариативности составляют права получателей (статья 9 Закона № 442-ФЗ, пункт 28 приказа № 935н), механизм взаимозаменяемости продуктов (приложение 6 к постановлению Минтруда № 12, приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), система стандартных диет (приказ Минздрава № 395н), региональные стандарты качества и локальные акты ^{[2][8][10][12][15]}.

В-третьих, регулирование носит дисперсный характер: нормы питания, стандарты качества, тарифы и порядки каждый из 89 субъектов формирует самостоятельно, что порождает межрегиональные различия, документируемые в разделе 3.

В-четвёртых, методическая база федерального уровня (постановление Минтруда № 12 от 15.02.2002) объективно устарела: она не отражает ни современной геронтологической диетологии, ни практики выбора блюд. Её актуализация — необходимое условие системного распространения вариативного меню.

Сводный реестр ключевых федеральных актов с верифицированными ссылками приведён в Приложении 1 настоящего доклада.

Раздел 3. Региональная нормативно-правовая база и опыт субъектов Российской Федерации

3.1. Модель регионального правового регулирования питания в учреждениях соцобслуживания

После вступления в силу Федерального закона № 442-ФЗ каждый субъект выстроил собственный блок актов, регулирующих питание в стационарных организациях соцобслуживания. Типовая архитектура этого блока едина для всех регионов и насчитывает четыре уровня:

Уровень	Типовое содержание	Примеры актов
Закон субъекта о социальном обслуживании	общие положения, формы, перечень услуг, полномочия органов	Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ ^[21] ; Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 34
Перечень социальных услуг	состав гарантированных и дополнительных услуг (включая обеспечение питанием)	постановления правительств субъектов
Нормы питания	суточные продуктовые наборы (г/сутки, брутто/нетто) по видам учреждений и категориям проживающих; диетические варианты	приказ ДТСЗН Москвы от 22.03.2021 № 228 ^[17] ; постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 ^[19] ; постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП ^[20] и др.
Порядки, стандарты, тарифы	порядок предоставления услуг, стандарты качества, подушевые нормативы финансирования, тарифы	приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214 ^[23]

Анализ региональных актов позволяет выделить три модели построения норм питания.

Первая — «многовариантная»: нормы дифференцированы не только по видам учреждений, но и по состоянию здоровья проживающих (отдельные наборы для лиц с сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и др.) — так построены нормы Санкт-Петербурга^[19]. **Вторая** — «типовая»: дифференциация по видам учреждений (дома-интернаты общего типа, дома ветеранов, психоневрологические интернаты), без выделения нозологических вариантов — примером служит Псковская область^[28]. **Третья** — «укрупнённая»: единый набор для всех учреждений с оговорками о замене продуктов по медицинским показаниям. Выбор модели предопределяет и

потенциал вариативного меню: чем богаче нормативный ассортимент, тем шире легальное пространство выбора блюд.

Отдельный региональный инструмент — **стандарты качества социальных услуг**: в них можно закрепить право проживающего на выбор блюд, периодичность обновления меню, наличие информации о меню в доступной форме, проведение опросов удовлетворённости. Именно на уровне стандартов и локальных актов в российской практике чаще всего «поселяется» вариативное меню.

3.2. Город Москва

Нормативная база. Основа социального обслуживания в столице — Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения в городе Москве» (с изменениями). Перечень социальных услуг и порядок их предоставления утверждены постановлениями Правительства Москвы. Нормы питания утверждены **приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.03.2021 № 228 «Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города Москвы»**, вступившим в силу с 01.04.2021 и заменившим ранее действовавший акт ^{[17][18]}.

Московские нормы построены по многовариантной модели: суточные продуктовые наборы дифференцированы по видам организаций (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, дома милосердия и др.) и предусматривают диетическое питание по медицинским показаниям. Акт установил: замена продуктов производится по нормам взаимозаменяемости, а питание организуется в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ^[17].

Организационная модель и практика вариативности. Стационарное обслуживание ветеранов труда и пожилых москвичей ведёт сеть пансионатов, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты (среди них — крупные комплексы, обслуживаемые с привлечением профессиональных операторов питания). В московской практике питание пансионатов строится по цикличному меню с элементами выбора: проживающим предлагают варианты блюд, проводят дегустации и опросы удовлетворённости, корректируют меню с учётом пожеланий жильцов. Такой подход отвечает позиции Департамента о персонификации услуг и подкреплён городскими стандартами качества. Московский опыт показателен сочетанием трёх факторов: детализированные нормы питания, профессиональная организация пищеблоков (в том числе кейтеринг) и институционализированная обратная связь с проживающими.

Оценка. Москва демонстрирует «ресурсно-обеспеченную» модель: вариативность здесь достигается не нормативным императивом (прямого требования выбора блюд городские акты не содержат), а сочетанием достаточного финансирования, зрелой управленческой культуры и конкурентной среды операторов питания. Слабое место модели — её плохая переносимость в регионы с дефицитными бюджетами.

3.3. Город Санкт-Петербург

Нормативная база. В Санкт-Петербурге социальное обслуживание регулирует Закон Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» и подзаконные акты. Нормы питания утверждены **постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»** (в редакции постановлений от 27.07.2017 № 616, от 19.12.2019 № 929, от 27.06.2022 № 561; распространяется на правоотношения с 01.01.2015) ^[19].

Постановление № 1284 — самый детализированный из проанализированных региональных актов. Нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов при стационарном обслуживании заданы в граммах на человека в сутки (брутто и нетто) **по четырём вариантам рациона**: (1) учреждения соцобслуживания, за исключением психоневрологических интернатов; (2) психоневрологические интернаты; (3) лица с заболеванием сахарным диабетом; (4) лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта ^[19]. Набор включает свыше сорока позиций: хлеб ржаной и пшеничный, мука, макаронные изделия, крупы и бобовые, овощи (свежие, солёные, консервированные), картофель, фрукты и ягоды свежие, сухофрукты, соки (в том числе сок без сахара — для диабетического варианта), мясо, птица, колбасные изделия, рыба, сыр, яйца, молоко и кисломолочные продукты, творог, сметана, масло сливочное и растительное, сахар и кондитерские изделия, чай, кофе, соль, дрожжи, томат, шиповник и др. ^[19].

Показательно сопоставление отдельных позиций по вариантам рациона (граммы в сутки, нетто): хлеб ржаной — 150/150/250/150; картофель — 168/268/44/126,2; фрукты и ягоды свежие — 200/100/385/200; овощи в сумме — 318/380/402/233,6 соответственно для общего, ПНИ-, диабетического и гастроэнтерологического вариантов ^[19]. Эта дифференциация свидетельствует: диабетический вариант рациона в Петербурге принципиально перестроен — снижены картофель и крупы, увеличены фрукты и овощи, введён сок без сахара. Региональный акт носит не формальный, а диетологически содержательный характер. Примечательно и другое: общая и ПНИ-нормы Санкт-

Петербурга включают специализированные продукты — смесь белковую композитную сухую (27 г в сутки) и витаминно-минеральные комплексы (1 драже три раза в неделю, через день) ^[19]. Для полустационарной формы акт задаёт структуру рациона в процентах от стационарной нормы: завтрак — 30 %, обед — 40 %, полдник — 10 %, ужин — 20 % ^[19].

Значение для вариативного меню. Многовариантная структура норм Санкт-Петербурга создаёт нормативную почву для выбора: в пределах четырёх рационов и таблиц взаимозаменяемости учреждение вправе предлагать проживающим альтернативные блюда, не нарушая норм. Практика петербургских учреждений включает цикличные меню с альтернативными позициями; в образовательных учреждениях города рассматривается пилотный проект «Система свободного выбора “Вариативное меню”» (по данным доклада Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 год) — подход перекочёвывает и в смежные социальные системы ^[34].

Оценка. Санкт-Петербург представляет «нормативно-диетологическую» модель: ставка сделана на тонкую дифференциацию норм по состоянию здоровья. Вариативность по вкусовым предпочтениям остаётся на усмотрение учреждений, но нормативная база для неё здесь самая благоприятная среди проанализированных регионов.

3.4. Свердловская область

Нормативная база. Социальное обслуживание в области регулирует Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» ^[21]. Нормы питания утверждены **постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП**, сменившим ранее действовавший акт (прежняя редакция — постановление № 1037-ПП) ^{[20][22]}.

Свердловские нормы примечательны тем, что в суточный продуктовый набор прямо включены **смесь белковая композитная сухая (27 г в сутки) и витаминно-минеральные комплексы** — элементы обогащения рационов, соответствующие федеральным методическим рекомендациям (МР 2.3.0144-19) и нормам лечебного питания (приказ Минздрава № 395н) ^{[20][13]}. Акт устанавливает порядок замены продуктов по таблице взаимозаменяемости (приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и содержит отсылки ко всему актуальному массиву санитарного законодательства: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (постановление от 27.10.2020 № 32), СП 2.4.3648-20 (постановление от 28.09.2020 № 28), СП 2.1.3678-20 (постановление от 24.12.2020 № 44), СанПиН 1.2.3685-21 (постановление от 28.01.2021 № 2) ^[20]. Такая связанность регионального акта с

федеральной санитарной базой — признак зрелого нормотворчества: нормы питания не существуют в отрыве от технологических требований к их исполнению.

Значение для вариативного меню. Свердловская модель показывает: региональные нормы способны быть инструментом не только количественного, но и качественного обеспечения рационов. Включение специализированных продуктов (СБКС, ВМК) расширяет возможности формировать варианты блюд повышенной пищевой ценности для ослабленных проживающих. Требования выбора блюд акт при этом не закрепляет — здесь, как и в большинстве регионов, вариативность остаётся организационной опцией учреждения.

3.5. Нижегородская область

Нормативная база. Система социального обслуживания Нижегородской области выстроена по типовой четырёхуровневой модели: закон области о социальном обслуживании, перечень социальных услуг, нормы питания (постановление Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709), порядок предоставления социальных услуг и ведомственные акты, в том числе приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214 ^[23]. Нормы дифференцированы по видам стационарных учреждений и категориям проживающих; диетическое питание организуется по медицинским показаниям с заменой продуктов по нормам взаимозаменяемости.

Практика. Нижегородская область принадлежит к регионам, активно развивающим стандарты качества социальных услуг: ведомственные акты закрепляют требования к информированию проживающих об услугах и порядок учёта индивидуальных потребностей в индивидуальных программах. На уровне учреждений (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты) действуют цикличные меню; элементы выбора блюд внедряются по инициативе учреждений в рамках норм.

Оценка. Нижегородская область иллюстрирует «стандартную» модель: нормативная база полностью соответствует федеральной рамке, но нормативного императива вариативности не содержит. Дальнейшее развитие зависит от региональных стандартов качества и управленческой инициативы учреждений.

3.6. Омская область

Нормативная база. Нормы питания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области утверждены **приказом от 11.11.2014 № 171-п**

уполномоченного регионального органа (ныне — Министерство труда и социального развития Омской области); акт действует в редакции последующих изменений ^{[24][26]}. Нормы задают суточные продуктовые наборы по видам учреждений и предусматривают диетическое питание при медицинских показаниях. Акт содержит принципиально важные отсылки: замена продуктов при составлении меню производится по нормам взаимозаменяемости федеральных Методических рекомендаций (постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12); организация питания — в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20; диетическое питание — с учётом статьи 25.5 Федерального закона № 29-ФЗ и статьи 39 Федерального закона № 323-ФЗ ^{[24][6][5]}.

Практика и прозрачность. Омская область примечательна открытостью учреждений: на официальных страницах домов-интернатов публикуются сведения об организации питания, перечни продуктов, запрещённых к выдаче и приёму в передачах (ограничения безопасности и санитарного режима), сведения о режиме приёмов пищи ^{[25][27]}. Публикация такой информации — элемент добровольной прозрачности, спутник зрелой культуры организации питания. Она создаёт предпосылки для вариативного меню: проживающие и их семьи знают рацион и могут участвовать в его обсуждении.

Оценка. Омская модель — «нормативно-прозрачная»: строгая связка с федеральными методическими документами плюс публичность учреждений. Вариативное меню нормативно не закреплено, но информационная инфраструктура для него — открытое меню, каналы обратной связи — уже существует.

3.7. Псковская область

Нормативная база. Нормы питания в стационарных организациях социального обслуживания Псковской области утверждены **приказом Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206** ^[28]. Документ принят в развитие областного законодательства о социальном обслуживании и устанавливает суточные нормы питания (в граммах, брутто и нетто) по категориям учреждений: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов, психоневрологические интернаты и другие стационарные организации ^[28].

Псковский акт интересен системностью ссылочного аппарата: в нём прямо названы федеральные ориентиры — нормы лечебного питания (приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н) и номенклатура стандартных диет (приказ Минздрава России от

05.08.2003 № 330), применяемые при организации диетического питания проживающих [28]^[12]. Это подтверждает установленную в докладе закономерность: региональные нормы питания социальных учреждений строятся на стыке социального и медицинского регулирования — количественную рамку задаёт субъект, а диетологическую логику заимствует из здравоохранения.

Значение для вариативного меню. Псковская модель — «типовая»: дифференциация наборов по видам учреждений без нозологических вариантов (в отличие от Санкт-Петербурга). Пространство для вариативного меню здесь уже, но оно сохраняется благодаря механизму взаимозаменяемости: в пределах одного набора учреждение вправе предлагать альтернативные блюда равной пищевой ценности.

3.8. Республика Татарстан

Нормативная база. В Республике Татарстан нормы питания в организациях соцобслуживания утверждены актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (приложение о нормах питания); ведомство публикует также порядок предоставления социальных услуг поставщиками^[36]. Нормы дифференцированы по видам организаций и предусматривают диетическое питание.

Контрольный опыт, значимый для темы. Республика дала и показательный материал контрольно-надзорного свойства: аудит организации питания в психиатрическом стационаре (республиканская клиническая психиатрическая больница) выявил занижение фактических рационов против рекомендуемых норм при стоимости питания на койко-день порядка 224–310 рублей^[30]. Проверенное учреждение относится к системе здравоохранения, однако выводы аудита напрямую касаются и учреждений соцобслуживания: формальное наличие норм питания не гарантирует их фактического исполнения при недостаточном финансировании, а контроль обязан проверять не только документы, но и реальную пищевую ценность рациона. Для вариативного меню этот вывод ещё весомее: выбор блюд теряет смысл, если базовая норма фактически не обеспечена продуктами.

3.9. Новосибирская область: документированная практика вариативного питания

Самый показательный из найденных документированных кейсов внедрения именно **вариативного питания** в российском учреждении соцобслуживания — опыт ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» (Новосибирская область)^[29].

Согласно официальной публикации учреждения, в интернате действует система **вариативного питания**: проживающим несколько раз в неделю предлагают несколько вариантов блюд на выбор; выбор делается на основные приёмы пищи (завтрак и обед); перечень блюд для выбора формирует диетическая медицинская сестра с учётом норм питания и санитарных требований ^[29]. Кейс примечателен сразу по нескольким причинам. Во-первых, вариативность внедрена в **психоневрологическом интернате** — учреждении с наиболее уязвимым контингентом, где персонификация услуг даётся труднее всего: часть проживающих нуждается в помощи при выборе. Во-вторых, модель построена без изменения норм питания: выбор организован внутри утверждённого продуктового набора и меню. Это подтверждает ключевой тезис доклада — вариативное меню не требует новых норм, оно требует организации. В-третьих, ключевой фигурой внедрения стал диетологический персонал — диетическая медицинская сестра; вот и кадровое условие успеха.

Новосибирский кейс документирует и типовую технологическую цепочку вариативного питания: планирование ассортимента вариантов → информирование проживающих → сбор выбора → приготовление вариантов → подача с учётом выбора → контроль остатков и корректировка ассортимента. Эта цепочка воспроизводима в любом учреждении — при наличии управленческой воли и минимального методического сопровождения (см. рис. 3 в разделе 4).

3.10. Кейтеринговая модель организации питания как фактор вариативности

Отдельным направлением региональной практики стала передача организации питания специализированным операторам — кейтеринг. Профессиональные операторы, работающие в социальной сфере, предлагают учреждениям цикличные меню с вариантами блюд, сезонную ротацию ассортимента, праздничные меню, учёт диетических потребностей, документирование по СанПиН и технологические карты ^[33]. Кейтеринг потенциально повышает вариативность за счёт масштаба производства, профессиональных технологов и логистики. Его риски — отчуждение функции питания от учреждения, зависимость качества от добросовестности оператора и необходимость жёсткого контрактного контроля (техническое задание с показателями вариативности, дегустационные комиссии с участием проживающих, штрафные механизмы). Юридически обе модели — собственный пищеблок и кейтеринг — равноправны; ответственность перед

проживающими в любом случае несёт учреждение соцобслуживания как поставщик социальных услуг.

3.11. Сравнительный анализ региональных нормативных актов о нормах питания

Обобщение проанализированных региональных актов представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Сравнительная характеристика региональных актов о нормах питания в стационарных учреждениях (организациях) социального обслуживания

Субъект РФ	Акт	Год принятия	Дифференциация норм	Диетические варианты	Специализированные продукты (СБКС/ВМК)	Связь с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
г. Москва	приказ ДТСЗН г. Москвы от 22.03.2021 № 228 ^[17]	2021	по видам организаций	по медицинским показаниям	предусмотрено обогащение	прямая отсылка
г. Санкт-Петербург	постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 ^[19]	2014 (ред. 2017, 2019, 2022)	по видам учреждений + по состоянию здоровья	отдельные нормы: сахарный диабет, заболевания ЖКТ	СБКС 27 г и ВМК (1 драже через день) — в составе общей и ПНИ-нормы	косвенная
Свердловская область	постановление Правительства от 10.11.2022 № 765-ПП ^[20]	2022	по видам учреждений	по медицинским показаниям	СБКС 27 г, ВМК — в составе набора	прямая отсылка (прил. 11 — замена)
Нижегородская область	постановление Правительства от 20.10.2014 № 709; приказ МСП от 21.04.2022 № 214 ^[23]	2014/2022	по видам учреждений	по медицинским показаниям	не выделены	косвенная
Омская область	приказ от 11.11.2014 № 171-п ^[24]	2014	по видам учреждений	по медицинским показаниям	не выделены	прямая отсылка (СанПиН 3590-20, 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20)

Псковская область	приказ КСЗН от 14.07.2020 № 206 ^[2] _{8]}	2020	по видам учреждений	со ссылкой на приказы № 330, № 395н	не выделены	косвенная
Республика Татарстан	акт Минтруда РТ (приложение о нормах питания) ^[3] _{6]}	2015–2021	по видам организаций	по медицинским показаниям	не выделены	косвенная

Таблица 3.2. Пример дифференциации норм питания по вариантам рациона: отдельные позиции постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1284 (граммы нетто в сутки на человека) ^[19]

Продукт	Общий рацион (кроме ПНИ)	ПНИ	Сахарный диабет	Заболевания ЖКТ
Хлеб ржаной	150	150	250	150
Хлеб пшеничный	100	200	10	150
Крупы, бобовые	80	49,6	111	53
Овощи (все виды)	318	380	402	233,6
Картофель	168	268	44	126,2
Фрукты и ягоды свежие	200	100	385	200
Сок без сахара	—	—	66	—

Таблица 3.2 наглядно показывает содержательный — а не декларативный — характер диетических вариантов в актах многовариантной модели: диабетический рацион принципиально отличается по углеводной составляющей (картофель снижен почти в четыре раза, фрукты увеличены почти вдвое, введён сок без сахара).

Сравнительный анализ высвечивает общие черты и различия регионального регулирования.

Общие черты: (1) все регионы утвердили нормы питания в 2014–2015 годах в исполнение Федерального закона № 442-ФЗ, а ряд субъектов актуализировал их в 2020–2022 годах после санитарной реформы; (2) структура норм единообразна — суточные продуктовые наборы в граммах (брутто/нетто) по видам учреждений; (3) диетическое питание повсюду привязано к медицинским показаниям; (4) механизм взаимозаменяемости продуктов закреплён повсеместно — через федеральные методические документы; (5) прямого требования вариативного меню — выбора блюд проживающим — не содержит ни один из проанализированных актов.

Различия: (1) степень детализации норм — от сорока с лишним позиций и четырёх вариантов рациона в Санкт-Петербурге до укрупнённых наборов; (2) включение специализированных продуктов (Свердловская область — СБКС и ВМК в норме); (3) орган и уровень акта — постановление правительства либо ведомственный приказ; (4) степень связанности с актуальным санитарным законодательством.

3.12. Проблемы регионального уровня регулирования и практики

Проблема 1. Финансирование и стоимость койко-дня. Главный ограничитель и норм питания, и вариативного меню — подушевой норматив финансирования. Контрольные мероприятия показывают: при низкой стоимости питания на человека в день (в проверенном татарстанском кейсе — порядка 224–310 рублей на койко-день) учреждение вынуждено экономить на ассортименте, а это несовместимо с вариативностью ^[30]. Вариативное меню объективно дороже единого: оно требует большего складского запаса, сложнее планируется и даёт больше отходов при ошибках прогнозирования выбора. При дефицитном нормативе оно возможно лишь за счёт управленческой эффективности — точного учёта выбора накануне и унификации полуфабрикатов.

Проблема 2. Разрыв между бумажной нормой и фактическим рационом. Аудиторская практика фиксирует расхождения между утверждёнными нормами и реальной закупкой и выдачей продуктов ^[30]. Проживающие и их семьи не всегда способны проверить соответствие. Отсюда значение прозрачности (публикация меню и норм, как в Омской области ^[25]) и внутреннего контроля (бракеражные комиссии с участием представителей проживающих).

Проблема 3. Кадровый дефицит. Организация вариативного питания требует диетологических компетенций (врач-диетолог или диетическая медицинская сестра), технологов, достаточного числа поваров. В ряде регионов дефицит таких кадров — объективный барьер; новосибирский кейс показывает, что ключевой фигурой внедрения стала именно диетическая медицинская сестра ^[29].

Проблема 4. Контингент с особыми потребностями. В ПНИ и геронтологических учреждениях значительная часть проживающих — при деменции, психических расстройствах, тяжёлой инвалидности — не всегда способна осознанно выбирать блюда. Для таких контингентов вариативное меню требует адаптированных форм: визуальные меню с фотографиями, помощь сотрудников при выборе, участие законных представителей, наблюдение за фактическими предпочтениями.

Проблема 5. Отсутствие методического сопровождения. Федеральные методические рекомендации 2002 года не описывают организацию выбора блюд; региональные методические центры сопровождают учреждения неравномерно. Учреждение, решившее внедрить вариативное меню, вынуждено проектировать процесс самостоятельно — с риском нарушить СанПиН (раздельное хранение вариантов, бракераж каждого варианта, документирование).

Выводы по разделу 3. Региональный уровень полностью сформировал обязательную количественную рамку питания — нормы, — но почти не закрепил качественную, то есть вариативность. Лучшие региональные практики: многовариантные нормы (Санкт-Петербург), включение специализированных продуктов (Свердловская область), прозрачность учреждений (Омская область), документированное внедрение вариативного питания (Новосибирская область), профессионализация питания пансионатов (Москва). Системного регионального закрепления права проживающего на выбор блюд не выявлено — и это пространство для нормотворчества (раздел 6).

Раздел 4. Организация вариативного меню: правовые основания, модели и методология внедрения

4.1. Правовые основания и ограничения внедрения

Для внедрения вариативного меню не нужно менять законодательство: оно реализуется в рамках действующих норм. Его правовые основания — права получателей социальных услуг (статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ, пункт 28 приказа № 935н): уважительное отношение, информация об услугах, отказ от услуги; механизм взаимозаменяемости продуктов (приложение 6 к постановлению Минтруда № 12, приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), позволяющий строить альтернативные блюда равной пищевой ценности; индивидуальная программа и договор (статьи 16, 17 Федерального закона № 442-ФЗ), фиксирующие индивидуальные потребности; региональные стандарты качества и локальные акты учреждения ^{[2][8][10][15]}.

Есть и ограничения: (1) нормы питания — каждый вариант блюда должен «укладываться» в суточный продуктовый набор; (2) СанПиН — технологические требования к приготовлению, хранению, раздаче и бракеражу распространяются на каждый вариант; (3) финансирование — вариативность не должна приводить к превышению норматива расходов; (4) медицинские противопоказания — выбор проживающего ограничен назначенной диетой; (5) требования безопасности для отдельных контингентов (ограничение острых, копчёных, трудножующихся продуктов; запреты отдельных продуктов в ПНИ и геронтологических учреждениях) ^[27].

4.2. Организационные модели вариативного меню

Практика — включая документированный новосибирский кейс ^[29] — и логика производственного процесса позволяют выделить пять моделей вариативности.

Модель 1. «Двухвариантное меню» (выбор из двух). На основные приёмы пищи предлагаются два варианта ключевых блюд — скажем, два вторых блюда на обед, два варианта гарнира или каши на завтрак. Выбор фиксируется накануне: при подаче предыдущего приёма пищи или вечером. Модель минимально затратна и наиболее распространена; именно она реализована в Болотнинском ПНИ ^[29].

Модель 2. «Меню-заказ» (предварительный заказ из ассортимента). Проживающий на неделю вперёд выбирает блюда из утверждённого циклического меню-ассортимента (10–15 позиций на каждый приём пищи). Модель максимально персонализирована, но требует

развитого учёта — карточки выбора, программное обеспечение — и применима прежде всего для самостоятельных проживающих.

Модель 3. «Шведский стол» (буфетное самообслуживание). На линии раздачи выставляется ассортимент блюд, из которого проживающий сам комплектует приём пищи в рамках норм. Модель применима для мобильных проживающих в столовых; она требует контроля норм выдачи и санитарного сопровождения линии.

Модель 4. «Смешанная» (вариативность по дням). Выбор предоставляется не ежедневно, а несколько раз в неделю — как в новосибирском кейсе ^[29]; в остальные дни действует единое меню. Это компромисс между затратами и качеством.

Модель 5. «Событийная» (праздничные и сезонные меню). Вариативность реализуется через специальные меню к праздникам, национальным и сезонным датам, дням рождения проживающих. Регулярного выбора она не заменяет, но заметно повышает субъективное качество жизни.

Рис. 3. Модель организации вариативного питания в стационарном учреждении социального обслуживания



Рис. 3. Модель организации вариативного питания в стационарном учреждении социального обслуживания

4.3. Диетическое питание в системе вариативного меню

Диетическое питание — обязательная составляющая (пункт 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ^[8]. В системе вариативного меню диетические рационы выделяются в самостоятельные «треки»: проживающий с назначенной диетой (по типам стандартных диет приказа № 395н — щадящая, низкокалорийная и др. ^[12]) выбирает блюда внутри своего диетического трека. Технологически это выглядит так: базовое цикличное меню разрабатывается в двух и более диетических версиях; каждая версия содержит варианты выбора; взаимозаменяемость

продуктов применяется внутри диетических ограничений. Для лежачих проживающих и получателей зондового питания вариативность реализуется через выбор вкусовых характеристик — варианты протёртых блюд, специализированных смесей, — насколько это позволяет медицинская часть. Отдельного внимания заслуживает текстурная адаптация: измельчённая, протёртая, гомогенизированная пища для лиц с нарушениями жевания и глотания (дисфагия), а в геронтологических учреждениях это значительная доля проживающих.

4.4. Организация выбора: информирование и учёт предпочтений

Юридически значимая процедура выбора складывается из четырёх элементов.

Информирование: меню с вариантами доводится до проживающих в доступной форме — печатное меню в столовой и на этажах, визуальное меню с фотографиями блюд для лиц с когнитивными нарушениями, озвучивание вариантов сотрудниками. **Фиксация выбора:** выбор отмечается в листах выбора (по комнатам и отделениям) накануне — это даёт пищеблоку точную заявку и сводит отходы к минимуму. **Помощь при выборе:** для проживающих, неспособных выбрать самостоятельно, выбор делают сотрудники — с учётом наблюдаемых предпочтений и назначенной диеты; законные представители вправе участвовать в определении предпочтений (статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ такое участие не ограничивает) ^[2]. **Контроль исполнения:** при подаче выданное сверяется с выбранным; расхождения регистрируются и анализируются.

Отдельный инструмент — регулярный учёт предпочтений: анкетирование проживающих (любимые и нелюбимые блюда), работа «советов столовых» или советов проживающих, дегустационные комиссии при вводе новых блюд. Эти практики прямо коррелируют с показателями качества из пункта 17 приказа № 935н — удовлетворённость, отсутствие обоснованных жалоб ^[15].

4.5. Документооборот, кадры и технология

Документальное сопровождение вариативного меню включает: (1) локальный акт учреждения (положение об организации питания или вариативного меню), утверждающий модель, периодичность, ответственных; (2) цикличное базовое меню (двух–четырёхнедельное) с вариантами блюд и диетическими версиями, согласованное с диетологическим персоналом; (3) меню-раскладки на каждый день с учётом суммированного выбора; (4) листы выбора проживающих; (5) журналы бракеража готовой продукции — по каждому варианту, журналы температурного режима, продуктовый учёт

(формы по приложениям к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ^[8]; (6) отчёты об удовлетворённости и анализ остатков.

Кадровое обеспечение: в идеале — врач-диетолог или диетическая медицинская сестра (расчёт меню, диетические треки), технолог или заведующий производством (технологические карты), повара в достаточной численности, сотрудники отделений (сбор выбора, помощь при выборе). Технологические условия: достаточная мощность пищеблока для параллельного приготовления вариантов, маркировка потоков, оборудование для поддержания температурных режимов при доставке в отделения.

4.6. Оценка качества и удовлетворённость проживающих

Эффективность вариативного меню измеряется системой показателей: удовлетворённость проживающих питанием (регулярные опросы); доля проживающих, активно пользующихся выбором; пищевой статус (динамика массы тела, ИМТ — по методике постановления Минтруда № 12 ^[10]); доля съедаемой пищи и объём пищевых отходов (косвенный индикатор приемлемости рациона); количество жалоб на питание; результаты внутренних проверок (бракераж) и внешнего контроля. Внедрение вариативного меню стоит сопровождать «нулевым» замером удовлетворённости и повторными измерениями — только так учреждение докажет эффект для ведомственной отчётности и общественного контроля.

4.7. Экономика вариативного меню

Стоимостная модель вариативного меню складывается из продуктового набора (по региональной норме и подушевому нормативу), дополнительных расходов на персонал и документооборот, потерь (отходы при ошибках прогноза выбора) и экономии (точная заявка по фактическому выбору снижает перепроизводство). При грамотной организации — выбор накануне, унифицированные полуфабрикаты, гибкая взаимозаменяемость — суммарные затраты близки к затратам единого меню; при кейтеринговой модели вариативность закладывается в техническое задание как измеримое требование (число вариантов, цикличность, опросы) с механизмами контроля и ответственности оператора ^[3]. Ограничение платы в 75 % (пункт 35 приказа № 935н) и подушевые нормативы регионов образуют жёсткий финансовый каркас, в пределах которого учреждение балансирует количество и качество ^[15].

4.8. Типовые ошибки и риски при внедрении вариативного меню

Практика и логика правового анализа позволяют назвать типовые ошибки, которых учреждениям стоит избегать. **Первая ошибка — «вариативность вне норм»:** предложение вариантов, выводящих рацион за пределы утверждённого продуктового набора (дополнительные позиции, не предусмотренные нормой, без соответствующего финансирования). Такая вариативность порождает нецелевое расходование и претензии контроля. Корректная модель — выбор внутри нормы через взаимозаменяемость ^{[8][10]}. **Вторая ошибка — формальный выбор:** варианты объявлены, но фактически подаётся одно блюдо; выбор проживающих не фиксируется и не сверяется с выдачей. Это дискредитирует идею и создаёт почву для обоснованных жалоб (пункт 17 приказа № 935н) ^[15]. **Третья ошибка — игнорирование диетических треков:** предложение проживающему вариантов, несовместимых с назначенной диетой. Выбор всегда ограничен медицинскими показаниями (пункт 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ^[8]. **Четвёртая ошибка — недокументированность:** нет ни локального акта, ни листов выбора, ни отдельного бракеража вариантов. При проверке учреждение не сможет подтвердить законность процесса. **Пятая ошибка — отсутствие оценки эффекта:** внедрение без нулевого и повторных замеров удовлетворённости; учреждение остаётся без аргументов, защищая практику перед учредителем и контролёрами.

Риски вариативного меню и способы их снижения: рост пищевых отходов (снимается точной заявкой по фиксированному выбору накануне); перегрузка персонала (снимается стартом с модели «несколько раз в неделю», как в новосибирском кейсе ^[29]); конфликты при подаче (снимаются маркировкой порций и сверкой с листами выбора); санитарные риски параллельного производства (снимаются технологическими картами и отдельными потоками); бюджетные риски (снимаются пилотным периодом с замером фактической себестоимости варианта).

Раздел 5. Контроль качества питания и защита прав проживающих

5.1. Государственный контроль (надзор): санитарный блок

Санитарный надзор за организацией питания в учреждениях соцобслуживания ведёт Роспотребнадзор — в системе риск-ориентированного контроля (Федеральный закон № 248-ФЗ, Федеральный закон № 52-ФЗ) ^[4]. Объекты питания относятся к категориям риска; для учреждений с постоянным проживанием уязвимых категорий характерна повышенная частота контроля. Предмет проверок: соблюдение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (помещения и оборудование пищеблока, приёмка и хранение продуктов, технология приготовления, температурные режимы, бракераж, личная гигиена и медицинские осмотры персонала, документация), наличие меню, соответствие фактического питания нормам, организация диетического питания (пункт 7.1.11) ^[8]. Типовые санкции: предостережения, предписания, административная ответственность (статья 6.3 КоАП РФ); при причинении вреда — гражданские иски и передача материалов в следственные органы.

Профилактические мероприятия — предостережения, информационные письма, методическая помощь — постепенно становятся главным инструментом. Учреждениям разумно выстраивать внутренний контроль так, чтобы внешний надзор лишь подтверждал его работоспособность (принципы НАССР по ТР ТС 021/2011).

5.2. Ведомственный и внутренний контроль

Ведомственный контроль качества социальных услуг осуществляют уполномоченные органы субъектов — министерства и департаменты социальной защиты — на основании статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ ^[2]. Формы: плановые проверки учреждений, мониторинг показателей качества (пункт 17 приказа № 935н), рассмотрение обращений граждан, экспертиза меню-раскладок и продуктового учёта ^[15]. Внутренний контроль учреждения включает бракеражные комиссии готовой продукции (с записью в журналах по формам СанПиН), контроль закладки продуктов в котёл (сверка с нормами), дегустации, учёт жалоб и предложений проживающих, самообследования по чек-листам СанПиН, инвентаризации продуктовых запасов. Для вариативного меню внутренний контроль дополняется сверкой «выбор — выдача» и анализом остатков по вариантам.

5.3. Прокурорский надзор и типовые нарушения

Прокуратура проверяет исполнение законодательства в интересах проживающих — и по обращениям, и планоно. Обобщение региональной прокурорской практики выявляет типовые нарушения в сфере питания учреждений соцобслуживания: (1) несоответствие фактического набора продуктов утверждённым нормам — «недовложение»; (2) замена продуктов с нарушением таблиц взаимозаменяемости; (3) отсутствие или формальное ведение меню-раскладок и журналов бракеража; (4) нарушение кратности и режима приёмов пищи; (5) неорганизованное диетическое питание при наличии медицинских показаний; (6) санитарные нарушения пищеблоков; (7) нарушения при расходовании средств на питание, в том числе при закупках. Реагирование — представления, протесты, дела об административных правонарушениях, иски в защиту прав проживающих. Для темы доклада прокурорская практика важна как зеркало: она показывает, что базовое исполнение норм питания в системе ещё не безусловно, — а значит, проекты вариативного меню должны стоять на прочном фундаменте исполнения обязательных требований.

5.4. Счётные палаты: аудит эффективности

Счётная палата Российской Федерации и региональные счётные палаты оценивают законность, результативность и эффективность расходования средств на соцобслуживание. В части питания предметом аудита становятся обоснованность нормативов, соответствие закупок нормам, стоимость питания на проживающего, результативность (пищевой статус, удовлетворённость). Кейс Республики Татарстан — психиатрический стационар, стоимость питания 224–310 рублей на койко-день при заниженных фактических рационах — показывает методологию таких проверок: сопоставление рекомендуемых и фактических норм, стоимостный анализ, выявление системных причин (недофинансирование) ^[30]. Рекомендации аудиторов традиционно включают актуализацию норм, усиление контроля исполнения и прозрачности.

5.5. Уполномоченные по правам человека: независимый мониторинг

Институт уполномоченных по правам человека ведёт независимый мониторинг интернатных учреждений. Тематический доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Социальное обслуживание» фиксирует масштаб системы (5 481 организация; более 1,4 тыс. стационарных учреждений; 517 стационарных отделений) и ключевые проблемы: доступность стационарного обслуживания, очереди (особенно в

ПНИ), условия проживания и питание, кадровый дефицит, ограничения прав проживающих; жалобы на условия и питание занимают устойчивое место в обращениях граждан ^[37]. Доклад подчёркивает необходимость развивать независимую оценку качества и общественный контроль — механизмы, при которых вариативность питания становится объективно измеримой характеристикой учреждения.

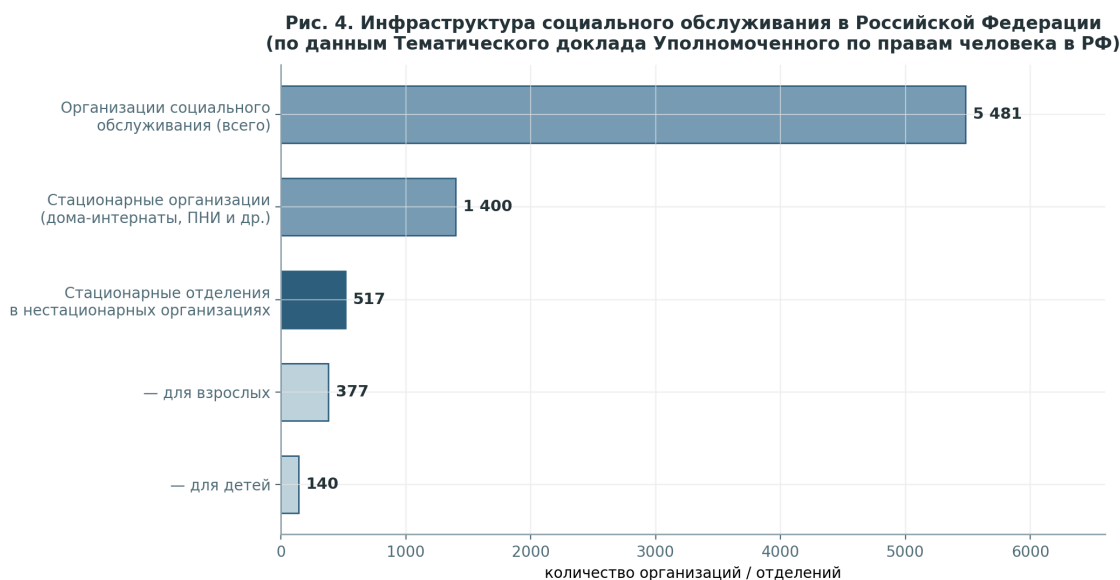


Рис. 4. Инфраструктура социального обслуживания в Российской Федерации (по данным Тематического доклада Уполномоченного по правам человека в РФ)

5.6. Общественный контроль и участие проживающих

Формы общественного контроля разнообразны: общественные наблюдательные комиссии (в учреждениях принудительного содержания — с определёнными ограничениями), советы попечителей учреждений, общественные палаты субъектов, деятельность НКО и волонтеров, «открытые двери» для родственников. Питание — самая «проверяемая» общественностью услуга: дегустации, осмотры пищеблоков, публикация меню, опросы проживающих. Омская практика публикации сведений о питании и перечней ограниченных продуктов на сайтах учреждений ^{[25][27]} — образец доступной прозрачности, повышающей доверие семей и снижающей конфликтность. В перспективе общественный контроль должен включать и оценку вариативности: наличие выбора, реальность его исполнения, учёт мнения проживающих при планировании меню.

5.7. Механизмы защиты прав проживающих в части питания

Система защиты прав выстраивается в несколько линий: (1) внутриучрежденческая — администрация, совет проживающих, книга отзывов; (2) ведомственная — обращения в уполномоченный орган субъекта; (3) надзорная — Роспотребнадзор, прокуратура; (4) правозащитная — уполномоченные по правам человека; (5) судебная — иски о защите прав потребителей услуг, о возмещении вреда; (6) общественная. Правовые основания требований к питанию: статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ, пункт 28 приказа № 935н (условия пребывания, надлежащий уход, информация), нормы питания региона, СанПиН, договор и индивидуальная программа ^{[2][15]}. Вариативное меню усиливает позиции проживающих: зафиксированный выбор — документальное подтверждение ожиданий, а его невыполнение — доказуемое нарушение.

Раздел 6. Проблемы правового регулирования и направления совершенствования

6.1. Выявленные пробелы регулирования

Проведённый анализ федеральной и региональной нормативно-правовой базы позволяет назвать шесть системных пробелов.

Пробел 1. Отсутствие понятия вариативного меню в законодательстве. Ни федеральные законы, ни подзаконные акты, ни проанализированные региональные акты не закрепляют ни самого понятия, ни права проживающего на выбор блюд. Вариативность существует как добровольная практика учреждений, а не как элемент гарантированного содержания услуги. Следствие — неравенство проживающих: возможность выбора зависит от места проживания и управленческой культуры конкретного учреждения, а не от закона.

Пробел 2. Устаревание федеральной методической базы. Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 — действующий, но морально устаревший документ: он не учитывает современные нормы физиологических потребностей (МР 2.3.1.0253-21), данные геронтологической диетологии, практику выбора блюд, требования информирования проживающих ^{[10][31]}. Регионы вынуждены развивать нормативную базу самостоятельно, без актуального федерального методического ориентира.

Пробел 3. Межрегиональная дифференциация норм. Передача нормотворчества субъектам (статья 8 Федерального закона № 442-ФЗ) без федеральных минимальных требований к структуре норм привела к существенным различиям в детализации, ассортименте и подходах к диетическому питанию (сравните многовариантную модель Санкт-Петербурга и типовые модели других регионов) ^{[19][28][2]}. Дифференциация финансирования умножает это неравенство.

Пробел 4. Недостаточная связность социального и медицинского регулирования. Диетическое питание в учреждениях соцобслуживания фактически регулируется актами системы здравоохранения (приказы № 330, № 395н), не адаптированными к специфике социальных учреждений: длительность проживания, отсутствие врачебного назначения диеты в ряде учреждений, особенности контингента ПНИ ^[12]. Граница компетенции Минтруда и Минздрава в части диетического питания проживающих недостаточно определена.

Пробел 5. Слабость механизмов подтверждения качества. Показатели качества (пункт 17 приказа № 935н) носят общий характер; единой методики измерения удовлетворённости

питанием нет; независимая оценка качества развита неравномерно ^[15]. Контроль сосредоточен на безопасности и количестве — нормы, СанПиН, — но не на субъективном качестве и выборе.

Пробел 6. Недостаток финансирования как системный ограничитель. Контрольная практика показывает: при низкой стоимости питания на человека в день даже обязательные нормы исполняются с трудом ^[30]; в таких условиях вариативное меню экономически недоступно без изменения нормативов или управленческих инноваций.

6.2. Предложения по совершенствованию (de lege ferenda)

Предложение 1. Закрепить понятие и принцип вариативности на федеральном уровне. Целесообразно дополнить подзаконные акты Минтруда России (Примерный порядок, приказ № 935н) положением о том, что при организации питания в стационарной форме получателю социальных услуг должна обеспечиваться возможность выбора блюд из не менее чем двух вариантов на основные приёмы пищи — с учётом норм питания, диетических назначений и возможностей учреждения. Такую формулировку можно ввести в стандарты социальных услуг сначала как рекомендуемый, а в перспективе — как обязательный элемент качества ^[15].

Предложение 2. Актуализировать методические рекомендации 2002 года. Минтруду России совместно с ФИЦ питания и биотехнологии стоит подготовить новую редакцию методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, включающую: обновлённые продуктовые наборы (с синхронизацией с МР 2.3.1.0253-21); модели вариативного меню (двухвариантное меню, меню-заказ, буфет); методику учёта выбора и предпочтений; требования к информированию проживающих; типовые формы документов (листы выбора, положение о вариативном меню); методику оценки удовлетворённости питанием ^{[10][31]}.

Предложение 3. Установить федеральные минимальные требования к структуре региональных норм питания. В целях сглаживания межрегионального неравенства нужны федеральные рамочные требования: обязательная дифференциация норм по видам учреждений; обязательные диетические варианты (не менее двух — щадящая и низкокалорийная/диабетическая); рекомендация включать специализированные продукты (СБКС, ВМК) по примеру Свердловской области ^[20]; периодичность пересмотра норм — не реже одного раза в пять лет.

Предложение 4. Развивать региональные стандарты качества с показателями вариативности. Субъектам следует включать в стандарты качества социальных услуг

измеримые характеристики: наличие выбора блюд (число вариантов, периодичность), опубликованное меню, периодичность опросов удовлетворённости, доля проживающих, охваченных выбором. Опыт Новосибирской области доказывает, что такие показатели реализуемы на практике ^[29].

Предложение 5. Урегулировать стык социального и медицинского регулирования диетического питания. Минтруду России и Минздраву России — совместно определить порядок назначения диетического питания проживающим учреждений соцобслуживания (в том числе при отсутствии штатного врача), перечень диетических вариантов и порядок документирования, адаптированный к социальной сфере ^[12].

Предложение 6. Усилить прозрачность и общественный контроль. Закрепить обязанность учреждений публиковать меню и сведения об организации питания (по примеру Омской области ^[25]); развивать советы проживающих и дегустационные комиссии с участием представителей проживающих и родственников; включать показатели питания в независимую оценку качества.

Предложение 7. Финансовое обеспечение. При расчёте подушевых нормативов учитывать затраты на вариативность (дополнительный ассортимент, документооборот, персонал); поддерживать региональные программы повышения стоимости питания на проживающего до уровня, обеспечивающего фактическое исполнение норм, — вывод, подтверждаемый аудиторской практикой ^[30].

6.3. Перспективы развития

Развитие вариативного меню в российских учреждениях соцобслуживания определяют три вектора. **Нормативный вектор:** постепенное закрепление права выбора блюд — сначала в региональных стандартах качества и методических документах, затем в федеральных подзаконных актах; по мере истечения срока действия СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (до 01.01.2027) возможна консолидация требований к питанию учреждений соцобслуживания в обновлённых санитарных правилах ^[7]. **Технологический вектор:** цифровизация выбора (электронные листы выбора, учёт предпочтений в информационных системах соцобслуживания), автоматизация меню-раскладок, развитие кейтеринговых технологий и логистики ^[33]. **Социальный вектор:** старение населения и рост числа долгоживущих проживающих повышают спрос на персонификацию услуг; поколение будущих проживающих будет требовательнее к выбору — и это превратит вариативное меню из опции в неизбежный стандарт. Международный опыт (включая практику стран СНГ, где

вариативность питания в интернатных учреждениях закреплена подзаконными актами) подтверждает реализуемость такого закрепления и в российском праве.

Заклучение

Проведённое исследование нормативно-правовой базы и регионального опыта позволяет сформулировать итоговые выводы.

1. Питание в стационарных учреждениях социального обслуживания Российской Федерации регулируется многоуровневой системой актов: конституционные нормы — Федеральный закон № 442-ФЗ — санитарные правила (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21) — ведомственные приказы Минтруда и Минздрава — методические рекомендации — национальные стандарты — акты субъектов Федерации — локальные акты учреждений ^{[1][2][7][10][12][15]}. Её обязательное ядро: включённость питания в социальные услуги, кратность не менее трёх приёмов пищи в день, обязательность диетического питания, соответствие региональным нормам и санитарным требованиям ^{[8][15]}.

2. Понятие «вариативное меню» в российском законодательстве не закреплено ни на одном уровне. Правовую основу вариативности составляют права получателей социальных услуг, механизм взаимозаменяемости продуктов, система стандартных диет и региональные стандарты качества; практическое внедрение носит инициативный характер ^{[2][8][10][12]}.

3. Региональный опыт нормирования питания сформировался полностью: все проанализированные субъекты утвердили нормы питания; сложились три модели (многовариантная — Санкт-Петербург; типовая — Псковская и Нижегородская области; укрупнённая). Лучшие практики: включение СБКС и ВМК в нормы (Санкт-Петербург, Свердловская область), прозрачность учреждений (Омская область), документированное внедрение вариативного питания в ПНИ (Новосибирская область), профессионализация питания пансионатов (Москва) ^{[17][19][20][24][25][28][29]}.

4. Документированная практика вариативного меню (Новосибирская область) доказывает: вариативность реализуема без изменения норм и без существенного роста затрат — за счёт организации выбора внутри утверждённого продуктового набора и при ключевой роли диетологического персонала ^[29].

5. Системные проблемы: отсутствие понятийного закрепления вариативности; устаревание методической базы 2002 года; межрегиональное неравенство норм и финансирования; разрыв социального и медицинского регулирования диетического питания; слабость измерения субъективного качества; случаи фактического неисполнения норм, выявляемые контрольными органами ^{[30][37]}.

6. Направления совершенствования: закрепление принципа вариативности в подзаконных актах; актуализация методических рекомендаций; федеральные минимальные требования к структуре региональных норм; показатели вариативности в стандартах качества; совместное регулирование диетического питания Минтрудом и Минздравом; прозрачность и общественный контроль; адекватное финансирование.

Вариативное меню — это не кулинарная роскошь, а юридически значимое измерение достоинства проживающих: реализация конституционного права на достойную жизнь и законного права получателя социальных услуг на уважительное отношение при предоставлении услуги, от которой каждый день зависят его здоровье и качество жизни. Перевод вариативности из разряда добровольных практик в разряд гарантированных характеристик услуги — ближайшая задача нормотворчества федерального и регионального уровней.

Приложение 1. Реестр нормативных правовых актов, регулирующих организацию питания в стационарных учреждениях социального обслуживания

Таблица П1.1. Федеральный уровень

№	Акт	Реквизиты	Предмет регулирования (в части темы доклада)	Источник
1	Конституция Российской Федерации	принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями)	ст. 7, 21, 39, 41 — основы социального государства, достоинство, социальное обеспечение, охрана здоровья	[1]
2	Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	от 28.12.2013 № 442-ФЗ	системообразующий акт: виды услуг, формы, полномочия субъектов (нормы питания), стандарты, плата (75 %), права получателей	[2]
3	Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	от 24.11.1995 № 181-ФЗ	гарантии инвалидам; стационарное обслуживание (ст. 17)	[3]
4	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	от 30.03.1999 № 52-ФЗ	обязательность санитарных требований; основа СанПиН и надзора	[4]
5	Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	от 21.11.2011 № 323-ФЗ	ч. 4 ст. 39 — утверждение норм лечебного питания	[5]

6	Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»	от 02.01.2000 № 29-ФЗ	понятия здорового и горячего питания; требования к пищевой продукции	[6]
7	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	в силе с 01.07.2013	обязательные требования безопасности; принципы HACCP	реквизиты в тексте
8	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	постановление ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32; в силе с 01.01.2021 до 01.01.2027	раздел 7.1 — питание в медорганизациях и организациях соцобслуживания: не менее 3 приёмов пищи в день, диетическое питание, бракераж, приложения (в т.ч. таблица взаимозаменяемости)	[7][8][9]
9	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений...»	постановление ГГСВ РФ от 24.12.2020 № 44	общие эксплуатационные требования	[31]
10	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности... факторов среды обитания»	постановление ГГСВ РФ от 28.01.2021 № 2	единые гигиенические нормативы	[31]
11	Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания	постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (с изм.)	суточные продуктовые наборы; примерные 7-дневные меню для домов-интернатов и ПНИ; нормы взаимозаменяемости; оценка адекватности питания	[10][11]
12	Приказ Минздрава России «Об утверждении норм лечебного питания»	от 21.06.2013 № 395н (ред. от 19.02.2024)	шесть стандартных диет; СБКС 27 г; ВМК 50–100 %	[12][13]
13	Приказ Минздрава России «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ»	от 05.08.2003 № 330 (с изм.)	номенклатура стандартных диет; организация диетпитания	реквизиты в тексте
14	Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка обеспечения пациентов лечебным питанием»	от 23.09.2020 № 1008н	организация лечебного питания	[14]

15	Приказ Минздрава России «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов...»	от 19.08.2016 № 614	ориентиры здорового рациона	[31]
16	МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»	утв. ГГСВ РФ 22.07.2021	физиологические нормы для лиц пожилого возраста	[31]
17	МР 2.3.0144-19 «Об организации питания в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения с использованием витаминно-минеральных комплексов»	утв. ГГСВ РФ 19.04.2019	обогащение рационов ВМК в организациях соцобслуживания	[31][35]
18	Приказ Минтруда России «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»	от 28.03.2014 № 159н	форма заявления (начало процедуры)	реквизиты в тексте
19	Приказ Минтруда России «Об утверждении Номенклатуры организаций социального обслуживания»	от 17.04.2014 № 258н	виды организаций соцобслуживания	реквизиты в тексте
20	Приказ Минтруда России «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»	от 24.11.2014 № 935н (ред. 2019, 2020)	п. 16 — учёт норм питания; п. 19 — качество питания; п. 28 — права получателей; п. 35 — плата до 75 %	[15][16]
21	ГОСТ Р 52884-2021 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг пожилым гражданам»	утв. Росстандартом в 2021 г.	требования к услугам пожилым (добровольное применение)	реквизиты в тексте
22	Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»	от 31.07.2020 № 248-ФЗ	риск-ориентированный надзор	реквизиты в тексте
23	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок...»	от 05.04.2013 № 44-ФЗ	закупки продуктов и кейтеринга	реквизиты в тексте

Таблица П1.2. Региональный уровень (проанализированные субъекты РФ)

№	Субъект РФ	Акт о нормах питания	Особенности	Источник
---	------------	----------------------	-------------	----------

1	г. Москва	приказ ДТСЗН г. Москвы от 22.03.2021 № 228 (в силе с 01.04.2021)	нормы по видам организаций; диетическое питание	[17] [18]
2	г. Санкт-Петербург	постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 (ред. 2017 № 616, 2019 № 929, 2022 № 561)	4 варианта рациона (общий, ПНИ, диабет, ЖКТ); СБКС 27 г, ВМК; структура полустационарного рациона 30/40/10/20 %	[19]
3	Свердловская область	постановление Правительства от 10.11.2022 № 765-ПП (прежняя ред. — № 1037-ПП)	СБКС 27 г, ВМК в норме; замена по прил. 11 СанПиН; закон области от 03.12.2014 № 108-ОЗ	[20] [21] [22]
4	Нижегородская область	постановление Правительства от 20.10.2014 № 709; приказ МСП от 21.04.2022 № 214	типовая модель	[23]
5	Омская область	приказ от 11.11.2014 № 171-п (с изм.)	отсылки к СанПиН 3590-20, 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, пост. Минтруда № 12; прозрачность учреждений	[24] [25] [26] [27]
6	Псковская область	приказ КСЗН от 14.07.2020 № 206	отсылки к приказам № 330, № 395н	[28]
7	Республика Татарстан	акт Минтруда РТ (приложение о нормах питания)	типовая модель; контрольный опыт — аудит питания (224–310 руб./койко-день)	[30] [36]
8	Новосибирская область	(нормы — на уровне области); практика ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ»	вариативное питание с 2024 г.	[29]

Приложение 2. Реестр верифицированных ссылок

Все ссылки ниже проверены на доступность прямым обращением к ресурсу **16 июля 2026 г.**; результат проверки — положительный (страница/файл доступны, содержание соответствует указанному документу). Нумерация соответствует номерам источников в тексте доклада.

Таблица П2.1. Верифицированные ссылки (проверка 16.07.2026 — доступны)

№	Сетевой адрес (URL)	Документ / содержание
1	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/	Конституция РФ
2	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
3	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
4	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
5	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
6	https://base.garant.ru/12117866/	Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ
7	https://base.garant.ru/74891586/	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГТСВ РФ от 27.10.2020 № 32)
8	https://pbprog.ru/regulation-docs/195695	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — полный текст (раздел 7.1, приложения)
9	http://yantarik.minobr63.ru/wp-content/uploads/санпин-питание-новый-1.pdf	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — PDF-копия
10	https://base.garant.ru/184396/	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (действующая редакция)
11	https://base.garant.ru/5365902/	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (первоначальная редакция)
12	https://base.garant.ru/70412098/	Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н

13	https://zdrav.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/06/01/Приказ_Минздрава_от_21.06.2013__395н_Об_утверждении_норм_лечебного_питания.pdf	Приказ № 395н — PDF
14	https://base.garant.ru/74703746/	Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н
15	https://base.garant.ru/70829256/	Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н
16	https://base.garant.ru/72240640/	Приказ Минтруда России от 05.04.2019 № 216н
17	https://base.garant.ru/405012407/	Приказ ДТСЗН г. Москвы от 22.03.2021 № 228 — Нормы питания
18	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=123071591&rdk=1&&empire=	Акт о нормах питания г. Москвы на портале правовой информации
19	https://csr-spb.ru/wp-content/uploads/2024/05/Постановление-1284.docx	Постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 (действующая редакция, текст проверен по файлу)
20	https://base.garant.ru/405688359/	Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП

21	https://www.gobogdanovich.ru/pub/static/108-OZ-03122014.pdf	Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ
22	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=160084472&page=1&rdk=2	Постановление Правительства Свердловской области № 1037-ПП (прежняя редакция)
23	https://base.garant.ru/404606671/	Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214
24	https://base.garant.ru/15588873/	Приказ от 11.11.2014 № 171-п — нормы питания Омской области
25	http://www.ditavrich55.ru/pitanie	Организация питания в государственном доме-интернате (Омская область) — практика
26	https://omsk-gov.ru/doc/51818	Официальная публикация акта Омской области о нормах питания
27	https://pni55.ru/perechen-zapreshchennyh-produktov	Перечень ограниченных продуктов в ПНИ (Омская область) — практика прозрачности

28	https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203529.pdf
29	https://bpni.nso.ru/news/2312
30	https://sprt.tatar/files/Otchet_Psih_2025.pdf
31	https://nios.ru/sites/default/files/documenty/spravochnaya-informaciya-sanitarno-epidemiologicheskoe-normirovanie.pdf
32	https://meganorm.ru/mega_doc/dop_fire_update_01052025/kodeks_rossiyskoy_federatsii_ob_administrativnykh/2/spravochn_epidemiologicheskoe.html
33	https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejting/

34	https://spbdeti.org/upload/iblock/357/f10ncjwqcpqic00z1kiskc8zw7jy26ow/ZAKS_2025.pdf	Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге (2024) — пилот «Система свободного выбора “Вариативное меню”» в образовательных учреждениях (PDF, содержание проверено)
35	https://ion.ru/upload/medialibrary/006/yqinaictruyeuq52gvht45xymidviz5h/	Методические рекомендации по применению специализированных пищевых продуктов диетического питания (ВМК) — PDF

Таблица П2.2. Источники, доступ к которым из автоматизированной исследовательской среды ограничен (географические/сетевые ограничения); приводятся по библиографическим реквизитам для ручной проверки

№	Документ	Реквизиты / адрес для ручной проверки
36	Нормы питания в организациях социального обслуживания Республики Татарстан (приложение к акту Минтруда РТ)	официальный сайт Минтруда РТ: mtsz.tatarstan.ru (раздел документов)
37	Тематический доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «Социальное обслуживание»	официальный сайт УПЧ РФ: ombudsmanrf.org (раздел «Доклады»)
38	Нормы питания Московской области	официальный сайт Минсоцразвития Московской области: msr.mosreg.ru
39	Мониторинг Минтруда России о количестве стационарных организаций	официальный сайт Минтруда России: mintrud.gov.ru
40	Тексты СанПиН и региональных актов в системе «Кодекс»	docs.cntd.ru (поиск по реквизитам акта)

41	ГОСТ Р 52884-2021 — текст стандарта	фонд стандартов Росстандарта / системы доступа к стандартам
----	-------------------------------------	---

Приложение 3. Извлечение из норм питания Санкт-Петербурга (постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284, действующая редакция)

Таблица ПЗ.1. Нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов при стационарной форме социального обслуживания: основные продуктовые позиции по четырём вариантам рациона (граммы нетто на одного человека в сутки) ^[19]

№	Продукт	Общий рацион (кроме ПНИ)	ПНИ	Сахарный диабет	Заболевания ЖКТ
1	Хлеб ржаной	150	150	250	150
2	Хлеб пшеничный	100	200	10	150
3	Мука пшеничная	45	45	17	40
4	Макаронные изделия	20	25	16	24
5	Крупы, бобовые	80	49,6	111	53
6	Овощи (все виды, зелень)	318	380	402	233,6
7	Картофель	168	268	44	126,2
8	Фрукты и ягоды свежие	200	100	385	200
9	Сухофрукты, шиповник	10	16	81	10
10	Соки плодово-ягодные, овощные	60	60	—	74
11	Сок без сахара	—	—	66	—
12	Говядина, свинина	90	70,5	55	57,8
13	Птица потрошённая	40	36,5	40	42,7
14	Колбаса и колбасные изделия	25	25	21	21

15	Рыба, рыбопродукты	41,8	46,7	30,8	26,4
16	Сыр	14	9,3	6,5	12,1
17	Яйцо	4 шт. в неделю	4 шт. в неделю	3,5 шт. в неделю	4 шт. в неделю
18	Молоко	200	200	240	213
19	Кисломолочные продукты	200	200	200	200
20	Творог	40	50	80	42
21	Масло сливочное	20	20	23	24
22	Масло растительное	20	20	21	14
23	Сметана	10	15	24	17
24	Сахар	57	57	15*	53
25	Смесь белковая композитная сухая	27	27	—	—
26	Витаминно-минеральные комплексы	1 драже 3 раза в неделю	1 драже 3 раза в неделю	—	—

* Сахар не входит в рецептуру блюд и выдаётся по заключению врача ^[19].

Структура рациона при полустационарной форме (в процентах от стационарной нормы):
завтрак — 30 %, обед — 40 %, полдник — 10 %, ужин — 20 % ^[19].

Приложение 4. Модель вариативного меню (рекомендуемый образец)

Ниже — рекомендуемый образец организации двухвариантного меню на один день для дома-интерната общего типа. Образец носит методический характер: конкретные блюда разрабатывает учреждение в пределах региональной нормы питания с применением таблиц взаимозаменяемости (приложение 6 к постановлению Минтруда № 12, приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и согласует с диетологическим персоналом ^{[8][10]}.

Таблица П4.1. Пример двухвариантного меню на один день

Приём пищи	Вариант А	Вариант Б	Диетический трек (щадящий)
Завтрак	Каша овсяная молочная, сыр, чай, хлеб с маслом	Запеканка творожная со сметаной, кофейный напиток, хлеб	Каша овсяная протёртая, чай, хлеб с маслом
Обед	Борщ со сметаной, котлета мясная с пюре, салат из свежей капусты, компот	Суп куриный с вермишелью, рыба запечённая с рисом, винегрет, сок	Суп-пюре овощной, суфле куриное паровое с пюре, кисель
Полдник	Кефир, булочка	Йогурт, печенье	Творожок, чай
Ужин	Гуляш с кашей гречневой, чай	Тефтели рыбные с картофельным пюре, чай	Омлет паровой, каша рисовая протёртая, чай

Таблица П4.2. Принципы построения недельного цикла вариативного меню

Принцип	Содержание
Неповторяемость	основные блюда не повторяются в течение дня; в течение недели — минимальное число повторов (по методике постановления Минтруда № 12)
Равноценность вариантов	варианты А и Б сбалансированы по пищевой ценности (взаимозаменяемость)
Диетическая совместимость	каждый вариант имеет диетические версии по назначенным диетам (приказ № 395н)
Выбор накануне	фиксация выбора проживающих не позднее чем за 12–16 часов до приёма пищи
Информирование	меню с вариантами публикуется заранее в доступной форме (печать, визуальные меню)
Контроль	бракераж каждого варианта; сверка «выбор — выдача»; еженедельный анализ остатков

Обратная связь	ежемесячный учёт популярности вариантов; корректировка цикла по итогам опросов
----------------	--

Приложение 5. Чек-лист внедрения вариативного меню в учреждении социального обслуживания

Практический инструмент для администрации учреждения. Чек-лист составлен на основе анализа нормативных требований и документированной практики ^{[8][10][15][29]}.

Блок 1. Нормативная готовность

- изучены актуальные региональные нормы питания и порядок замены продуктов (таблицы взаимозаменяемости);
- проверена актуальность редакций СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и иных санитарных правил;
- определены диетические треки, применяемые в учреждении (по приказу № 395н и медицинским показаниям проживающих);
- издан локальный акт (положение об организации питания / вариативного меню).

Блок 2. Меню и технология

- разработано цикличное базовое меню (2–4 недели) с вариантами блюд и диетическими версиями;
- варианты сбалансированы по пищевой ценности в пределах нормы (проверка расчётом);
- подготовлены технологические карты вариантов; определены потоки приготовления и раздачи;
- предусмотрены текстурные версии (протёртые блюда) для нуждающихся.

Блок 3. Организация выбора

- утверждена форма листов выбора (по отделениям/комнатам) и порядок их сбора (накануне);
- меню с вариантами доводится до проживающих в доступной форме (печать, визуальные меню);
- определён порядок помощи при выборе для проживающих, не способных выбрать самостоятельно;
- определён порядок учёта предпочтений (анкетирование, совет проживающих).

Блок 4. Контроль и документация

- бракераж проводится по каждому варианту; журналы ведутся по формам СанПиН;

- организована сверка «выбор — выдача» при подаче;
- ведётся учёт остатков по вариантам и еженедельный анализ;
- проведён нулевой замер удовлетворённости питанием; назначены повторные замеры.

Блок 5. Персонал и ресурсы

- определены ответственные (диетическая медицинская сестра/диетолог, технолог, завпроизводством);
- персонал проинструктирован о порядке вариативного меню;
- оценена достаточность мощности пищеблока и оборудования для параллельного приготовления;
- при кейтеринге — требования вариативности включены в техническое задание и контракт.

Приложение 6. Проект типового положения об организации вариативного меню (образец локального акта)

Ниже — рекомендуемый каркас локального акта учреждения. Образец носит методический характер и подлежит адаптации к региональным нормам и уставным документам учреждения.

1. Общие положения. Настоящее Положение определяет порядок организации вариативного меню в учреждении в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нормами питания субъекта Российской Федерации и Примерным порядком (приказ Минтруда России № 935н). Вариативное меню организуется в целях повышения качества социальных услуг, учёта предпочтений проживающих и реализации их прав на информацию и уважительное отношение.

2. Основные принципы. Выбор блюд осуществляется в пределах утверждённых норм питания; варианты равноценны по пищевой ценности; диетические назначения имеют приоритет над выбором; участие в выборе добровольно; проживающий вправе отказаться от выбора (тогда ему предоставляется основной вариант).

3. Ассортимент и периодичность. На основные приёмы пищи (завтрак, обед) предлагается не менее двух вариантов основных блюд; периодичность — ежедневно либо не менее трёх раз в неделю (по решению учреждения с учётом ресурсов); праздничные и сезонные меню — по календарю.

4. Порядок выбора. Меню с вариантами публикуется не позднее чем за два дня; выбор фиксируется в листах выбора накануне до 16:00; помощь при выборе оказывают сотрудники отделений; для проживающих, не способных выбрать самостоятельно, выбор осуществляется сотрудником с учётом наблюдаемых предпочтений и диетических назначений.

5. Приготовление и подача. Приготовление вариантов ведётся по технологическим картам; каждый вариант проходит бракераж; подача — по листам выбора с маркировкой; для лежащих проживающих подача организуется в комнаты с соблюдением температурных режимов.

6. Контроль и оценка. Администрация еженедельно анализирует остатки и исполнение выбора; ежемесячно — популярность вариантов; не реже двух раз в год проводится опрос удовлетворённости питанием; результаты учитываются при актуализации циклического меню.

7. Ответственность и документы. Ответственные: за меню и диетические треки — диетическая медицинская сестра (диетолог); за технологию — заведующий производством; за сбор выбора — старшие сотрудники отделений. Перечень документов: листы выбора, меню-раскладки, журналы бракеража, отчёты анализа, отчёты опросов.

Приложение 7. Глоссарий

Вариативное меню (вариативное питание) — модель организации питания, при которой проживающему предлагается выбор из двух и более вариантов блюд в рамках утверждённых норм питания (рабочее определение настоящего доклада).

Диетическое (лечебное) питание — питание, организуемое по медицинским показаниям в соответствии с нормами лечебного питания (приказ Минздрава России № 395н).

Индивидуальная программа — документ, определяющий виды, объём, периодичность и условия предоставления социальных услуг конкретному получателю (статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ).

Меню-раскладка — технологический документ пищеблока: расчёт количества продуктов на приготавливаемые блюда по утверждённому меню и числу питающихся.

Нормы питания — утверждённый субъектом Российской Федерации суточный продуктовой набор (в граммах брутто/нетто) для организаций социального обслуживания.

Подушевой норматив финансирования — установленная субъектом Российской Федерации величина бюджетных расходов на одного получателя социальных услуг.

Полустационарная форма — социальное обслуживание с дневным пребыванием (без ночёвки) в организации социального обслуживания.

СБКС — смесь белковая композитная сухая, специализированный продукт лечебного питания.

Социальная услуга — действие (действия) по оказанию помощи, содействию, поддержке, уходу, защите интересов получателя (статья 2 Федерального закона № 442-ФЗ).

Стационарная форма социального обслуживания — форма с постоянным, временным или пятидневным круглосуточным проживанием в организации социального обслуживания (статья 3 Федерального закона № 442-ФЗ).

Стандарт социальной услуги — установленные основные требования к объёму, периодичности и качеству предоставления услуги (статья 2 Федерального закона № 442-ФЗ).

Срочные социальные услуги — услуги, предоставляемые при обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности (в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов).

Таблица взаимозаменяемости продуктов — нормативный инструмент замены одних продуктов другими с сохранением пищевой ценности рациона (приложение 6 к постановлению Минтруда № 12; приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Бракераж готовой продукции — обязательный контроль качества готовых блюд перед раздачей с записью в журнале бракеража (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Кейтеринг — организация питания силами специализированного оператора по договору.

ВМК — витаминно-минеральный комплекс, применяемый для обогащения рационов (МР 2.3.0144-19).

Дисфагия — нарушение глотания; основание для текстурной адаптации пищи (протёртые, гомогенизированные блюда).

Источники

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями). Текст: СПС «КонсультантПлюс» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (проверено 16.07.2026).
2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (проверено 16.07.2026).
3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (проверено 16.07.2026).
4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (проверено 16.07.2026).
5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (проверено 16.07.2026).
6. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» — <https://base.garant.ru/12117866/> (проверено 16.07.2026).
7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (постановление ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32) — <https://base.garant.ru/74891586/> (проверено 16.07.2026).
8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: полный текст (раздел 7.1, приложения) — <https://pbprog.ru/regulation-docs/195695> (проверено 16.07.2026).
9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: PDF-копия — <http://yantarik.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-1.pdf> (проверено 16.07.2026).
10. Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания...» (действующая редакция) — <https://base.garant.ru/184396/> (проверено 16.07.2026).
11. Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (первоначальная редакция) — <https://base.garant.ru/5365902/> (проверено 16.07.2026).

23. Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214 — <https://base.garant.ru/404606671/> (проверено 16.07.2026).
24. Приказ от 11.11.2014 № 171-п «Об утверждении норм питания...» (Омская область) — <https://base.garant.ru/15588873/> (проверено 16.07.2026).
25. Организация питания в государственном доме-интернате для престарелых и инвалидов (Омская область) — <http://www.ditavrich55.ru/pitanie> (проверено 16.07.2026).
26. Официальная публикация акта Омской области о нормах питания — <https://omsk.gov.ru/doc/51818> (проверено 16.07.2026).
27. Перечень ограниченных продуктов в психоневрологическом интернате (Омская область) — <https://pni55.ru/perechen-zapreshchennyh-produktov> (проверено 16.07.2026).
28. Приказ Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206 «Об утверждении норм питания...» — <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203529.pdf> (проверено 16.07.2026).
29. Вариативное питание в ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» (Новосибирская область) — <https://bpni.nso.ru/news/2312> (проверено 16.07.2026).
30. Отчёт контрольного органа Республики Татарстан об аудите организации питания — https://spirt.tatar/files/Otchet_Psih_2025.pdf (проверено 16.07.2026).
31. Справочная информация о санитарно-эпидемиологическом нормировании (МР 2.3.1.0253-21; МР 2.3.0144-19; СП 2.1.3678-20; СанПиН 1.2.3685-21; приказ Минздрава № 614) — <https://nios.ru/sites/default/files/documenty/spravochnaya-informaciya-sanitarno-epidemiologicheskoe-normirovanie.pdf> (проверено 16.07.2026).
32. Справочная информация о санитарном законодательстве — https://meganorm.ru/mega_doc/dop_fire_update_01052025/kodeks_rossiyskoy_federatsii_ob_administrativno-epidemiologicheskoe.html (проверено 16.07.2026).
33. Кейтеринг в социальных учреждениях: обзор модели — https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtering/ (проверено 16.07.2026).
34. Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге (2024): пилот «Система свободного выбора “Вариативное меню”» — https://spbdeti.org/upload/iblock/357/f10ncjwqcpqic00z1kiskc8zw7jy26ow/ZAKS_2025.pdf (проверено 16.07.2026; содержание изучено по файлу).

35. Методические рекомендации по применению специализированных пищевых продуктов диетического питания (витаминно-минеральных комплексов) — <https://ion.ru/upload/medialibrary/006/yqinaictruyeuq52gvht45xymidviz5h/> (проверено 16.07.2026).
36. Нормы питания в организациях социального обслуживания Республики Татарстан (приложение к акту Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ) — официальный сайт Минтруда РТ mtsz.tatarstan.ru (доступ из автоматизированной среды ограничен; реквизиты для ручной проверки).
37. Тематический доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Социальное обслуживание» — официальный сайт УПЧ РФ ombudsmanrf.org (доступ из автоматизированной среды ограничен; реквизиты для ручной проверки).

Доклад подготовлен в информационных целях и не является официальным толкованием законодательства или юридической консультацией. Тексты нормативных правовых актов применяются в действующих редакциях; перед использованием рекомендуется сверить редакцию по официальным источникам.